

2026 年中医经典等级考试三级

详细读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

资料范围：《2020 年全国中医经典等级考试试点联考考试大纲（三级）》原书正文第 1–125 页（电子 PDF 第 5–129 页），涵盖《黄帝内经》《伤寒论》《金匱要略》及温病学选篇。
整理方式：逐页核对原 PDF，按病机、证候、治法、方证鉴别、禁忌和转归重组；正文引用同时标注电子 PDF 页码与页内原书页码。
版本提示：古籍存在异文，原 PDF 亦有 OCR 缺字。可确定者已校正并在相应章节说明，不能确定者保留校勘边界。

目录

1、 导读：四部经典如何构成一套辨证体系	4
1.1 资料范围与整理方法	4
1.2 从理论到临床的四层递进	4
1.3 贯穿全书的五个辨证问题	4
1.4 阅读与安全边界	5
2、 《黄帝内经》选篇详读笔记	5
2.1 阅读范围与核心体系	5
2.2 《素问》：从自然法则到辨证论治	6
2.3 《灵枢》：经络针刺与精气神的运行结构	11
2.4 跨篇整合：一套可操作的临床思维	14
2.5 所选篇章覆盖索引	15
2.6 校勘说明	19
3、 《伤寒论》六经辨证精读	20
3.1 六经辨证的总框架	20
3.2 太阳病：表证、兼证及误治变证	21
3.3 阳明病：胃家实、津伤与热证转归	26

3.4	少阳病：枢机不利，以和解为主	27
3.5	太阴病：中阳不足，寒湿内盛	27
3.6	少阴病：阳虚寒化与阴虚热化	28
3.7	厥阴病：阴阳不相顺接与寒热错杂	29
3.8	霍乱：吐利并作，先辨寒热与亡阳	30
3.9	阴阳易与差后劳复：病后调摄重在辨余邪与正虚	31
3.10	核心方证鉴别速查	31
3.11	校勘说明	32
4、	《金匱要略》精读笔记	33
4.1	阅读范围与总纲	33
4.2	脏腑经络先后病脉证第一：总纲与诊法	34
4.3	痉湿喝病脉证治第二：筋脉拘急与湿热水湿	34
4.4	百合狐惑阴阳毒病脉证治第三：心神失养与湿热虫毒	35
4.5	疟病脉证治第四：寒热往来与疟母	36
4.6	中风历节病脉证并治第五：络经腑脏与痹痛	37
4.7	血痹虚劳病脉证并治第六：营卫失和与虚劳内伤	38
4.8	肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七：肺失宣降与痈脓	39
4.9	奔豚气病脉证治第八：冲气与惊恐	40
4.10	胸痹心痛短气病脉证治第九：上焦阳虚与痰饮瘀阻	40
4.11	腹满寒疝宿食病脉证治第十：虚实寒热与腑气通降	41
4.12	五脏风寒积聚病脉证并治第十一：着、积、聚与三焦寒热	42
4.13	痰饮咳嗽病脉证并治第十二：四饮与水饮出路	42
4.14	消渴小便不利淋病脉证并治第十三：气化、津亏与淋证	43
4.15	水气病脉证并治第十四：五水、上下出路与黄汗	44
4.16	黄疸病脉证并治第十五：湿热、寒湿与三类黄疸	45
4.17	惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六：血逆与瘀阻	45
4.18	呕吐下利病脉证治第十七：胃气上逆与水谷失调	46
4.19	疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八：脓成与否	47
4.20	跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九：本节录条	48
4.21	妇人妊娠病脉证并治第二十：冲任、胞宫与妊娠用方	48
4.22	妇人产后病脉证治第二十一：血虚、亡津与瘀血	49
4.23	妇人杂病脉证并治第二十二：气郁、血瘀与胞系	50
4.24	综合辨证与临床学习要点	51
4.25	校勘说明	51

5、 温病学篇：从卫气营血到三焦辨治	52
5.1 全篇定位与阅读主线	52
5.2 《温热论》：卫气营血与临床征象	53
5.3 《湿热病篇》：湿热相合的辨证层次	54
5.4 《温病条辨》：三焦体系与方证阶梯	54
5.5 瘟疫学说与后世扩展	56
5.6 伏气、湿温与温伤之辨	57
5.7 综合辨证提要	57
5.8 校勘与用药说明	58
6、 跨典整合与复习索引	58
6.1 同一病机在不同经典中的展开	58
6.2 高频鉴别：先列证候，再选方	59
6.3 方证记忆的最小单元	59
6.4 考前复盘顺序	60
6.5 本次校勘的总体原则	60
7、 编者结语	61

1、 导读：四部经典如何构成一套辨证体系

1.1 资料范围与整理方法

本笔记依据《2020 年全国中医经典等级考试试点联考考试大纲（三级）》整理。原 PDF 共 129 页，其中前 4 页为封面与目录，正文依次选录《黄帝内经》《伤寒论》《金匱要略》及温病学文献。笔记没有逐条照抄，而是完成三步重组：先按原典篇章核对知识范围，再把同一病机和治法的分散条文归并，最后用方证鉴别、禁忌与传变关系把四部分贯通。文中的 PDF 页码是电子文件页码，“原书页码”是 PDF 正文印刷页码，二者相差 4 页。

原文条目前的（1）、（2）、（3）为大纲自带层级标记。由于文件没有在正文中给出标记释义，本笔记不擅自解释其权重，只在内容上做到全部覆盖；复习时仍可回到原 PDF 查看相应层级。

1.2 从理论到临床的四层递进

《黄帝内经》奠定“为什么”

以阴阳、五行、藏象、经络、气血津液解释人体常态，以四时、情志、饮食劳倦和六淫说明失常，再以治未病、调阴阳、辨虚实和因时因地制宜建立治疗原则。

《伤寒论》训练“怎样动态辨证”

六经不是六个孤立病名，而是外感病过程中病位、病性与正邪盛衰的组合。方剂是证候结构的回应，必须同时看主症、兼症、脉象、误治史和病势进退。

《金匱要略》扩展“怎样处理杂病”

杂病多病程较长、虚实夹杂，常围绕痰饮、水气、瘀血、虚劳和脏腑经络失调展开。其治法特别强调病机分层、同病异治和异病同治。

温病学补充“怎样处理温热、湿热与疫病”

卫气营血和三焦辨证细化了热邪、湿邪由浅入深的路径，也把舌诊、斑疹、神志和津液变化提升为关键判断依据。

四者可以压缩为一条临证推理链：

生理基准与病因 → 病位病性与邪正 → 证候及传变 → 治法方药与禁忌 → 疗效和转归复评

1.3 贯穿全书的五个辨证问题

1. 病在何处：表里、脏腑、经络、六经、卫气营血和三焦都是定位工具，须根据不同疾病选择合适坐标。
2. 病性为何：寒热、燥湿、气血津液失常及痰饮瘀血是定性维度；同一部位可有不同病性。
3. 邪正孰强：实证重在祛邪，虚证重在扶正，虚实夹杂则要决定先后缓急；“脉有力无力、神气存亡、胃气盛衰”常是关键。
4. 病势向何处走：传经、入里、逆传、下陷、外解、内闭均是方向判断。经典强调随证转法，不允许一张方从始用到终。

5. 治疗给邪何种出路：汗、吐、下、和、温、清、消、补之外，还包括宣肺、利小便、化湿、通络、开窍、凉血和养阴。选法既要逐邪，也要保护阳气、阴液与胃气。

阅读经典最忌“见方背方”。有效的记忆单位应是“证机-主症-脉舌-治法-主方-禁忌-转归”，方名只是这一结构的索引。

1.4 阅读与安全边界

本笔记服务于经典学习和考试复习，不是诊疗指南。古籍中的药名、剂量、炮制和煎服法具有历史语境，部分药物有毒性、强烈泻下作用或涉及现代禁限用药材。任何现实诊疗均须由合格中医师结合患者情况和现行法规决定，不可依笔记自行处方。

2、《黄帝内经》选篇详读笔记

2.1 阅读范围与核心体系

本笔记覆盖 PDF 第 5 页至第 39 页所收《内经篇》，即原书第 1 页至第 35 页。其中 PDF 第 5 页至第 29 页为《素问》选文，PDF 第 30 页至第 39 页首段为《灵枢》选文；PDF 第 39 页《大惑论第八十》之后已经进入《伤寒论篇》，不在本节范围内。

这些选文并非互不相干的格言汇编，而是构成了一条完整的医学推理链：天地四时与六气提供外部节律，阴阳五行说明变化关系，藏象与精气血津液说明生命活动，经络营卫说明物质与功能如何周流，病因病机说明失衡怎样形成，望闻问切把失衡转化为可观察的证候，最后以调阴阳、和气血、通经络、顾胃气、安神志为治疗目标。其临床判断可概括为以下五层：

1. 先识常，再识变。四时生长收藏、昼夜阴阳消长、脉有胃气，都是判断疾病的正常参照；离开正常节律，单个症状便难以定性。
2. 先辨关系，再定病名。阴阳不是静止标签，而是内外、升降、寒热、动静、形气相互依存又相互转化的关系；五行则用于说明脏腑、时令、五味和病势之间的生克制化。
3. 形、气、神合参。五脏藏精气神魂魄，六腑传化水谷，营卫气血行于脉内外；人的情志、体质、生活经历和治疗意愿都会改变病程，故不能只见局部病灶。
4. 以正邪、虚实、标本统摄病机。邪气之所以成病，既取决于风寒暑湿燥火等外因，也取决于精气是否亏虚、气机是否升降出入有常。治疗必须判断何者为本、何者为标，何者当先、何者当后。
5. 治疗以恢复动态平衡为期。针、灸、砭石、汤药、饮食、导引按跷各有所宜，但共同目的都是疏通壅滞、补不足、泻有余，使阴阳气血重新各守其位，而不是机械追逐症状。

《阴阳应象大论》用一句话点明全书的方法论：

“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。治病必求于本。”

这里的“本”不是某一固定脏器，而是疾病背后的阴阳失调及其所在层次。后文所有藏象、病机、诊法和治则，都是这一总原则的展开。

2.2 《素问》：从自然法则到辨证论治

2.2.1 养生、生命节律与治未病

生命以肾精为本，并呈阶段性消长。《上古天真论》以女子七岁、男子八岁为节律，说明肾气、天癸、任脉、太冲脉与生殖、生长、衰老相互关联。其重点不只是年龄数字，而是指出生命力有“盛、平、衰、竭”的过程：女子二七、男子二八以后生殖条件渐备，盛年筋骨肌肉充实，继而阳明、三阳、肝肾渐衰，最终天癸竭而生殖能力止。年老仍能生子者，被解释为天寿较长、气脉常通、肾气有余；“知道者”则能以养生延缓形体败坏。这一模型为儿科生长、妇科月经生殖、老年筋骨衰退提供了统一的肾精视角。

“法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱。”

PDF 第 5 页（原书第 1 页）

“形与神俱”把养生目标限定为身心共同完整。节饮食、常起居、不过劳是养形；恬淡少欲、精神内守是养神。反面则是酒色无度、欲望耗精、起居失常，使人“半百而衰”。因此养生并非被动休息，而是在劳与逸、欲与节、外界刺激与内在安定之间维持适度。

四时养生是顺应生长收藏。《四气调神大论》将春、夏、秋、冬分别概括为发陈、蕃秀、容平、闭藏，并把作息、活动、情志和护阳方式逐一配合：春宜舒展生发，夏宜使气宣泄，秋宜收敛神气，冬宜早卧晚起、避寒就温而不妄泄皮肤。逆春伤肝、逆夏伤心、逆秋伤肺、逆冬伤肾，而且当季之伤会削弱下一季的生长收藏，形成跨季伏发。所谓“春夏养阳，秋冬养阴”，并不是四季只补某一方，而是保护当令之气的功能方向。

本篇进一步提出“治未病”：疾病已经形成后才用药，如同口渴才掘井、临战才铸兵，时机已晚。其临床含义有三：在未病时调生活，在欲病时识微兆，在已病时防传变。

阳气卫外，阴精为根。《生气通天论》将阳气比作天日，强调其温煦、卫外、推动和昼夜开阖功能。平旦阳气生，日中盛，日西渐虚，入暮腠理应收闭；若暮夜仍扰筋骨、冒雾露，便逆其节律。寒、暑、湿、风、劳倦、暴怒、膏粱厚味及汗出当风，均可使阳气浮越、闭阻或耗散，继而出现煎厥、薄厥、偏枯、痿痹、痈肿、风疟等。与之相对，阴精负责内守和物质基础，阳气负责外固和功能活动。二者的理想状态不是谁压倒谁，而是“阴平阳秘”。

《金匱真言论》“夫精者，身之本也”承接这一思路：冬季封藏充足，精不妄泄，来春便不易因伏邪而发温病。由此可见，治未病既保护正气，也重视疾病的时间链条。

2.2.2 阴阳五行、运气与动态平衡

阴阳说明方向、层次与转化。《阴阳应象大论》把阳与动、气化、上升、外达相联，把阴与静、成形、下降、内藏相联；清阳应出上窍、充四肢、达腠理，浊阴应出下窍、归五脏六腑。若清气陷下则飧泄，浊气逆上则胀满，说明病变常表现为升降位置颠倒。阴阳又可继续分化，《阴阳离合论》所谓“数之可十，推之可百”，提醒临床不能把复杂病情压成僵硬二分，但万变仍须归结到阴阳关系。

气与味亦按阴阳分析：气偏于功能，味偏于形质；辛甘多发散，酸苦多涌泄，厚薄又决定作用强弱。“壮火”会散气耗气，“少火”则温养生气，提示温热药或机体阳热都须辨剂量和程度，过强便由生理之火转为病理之火。

五行是脏腑网络而非简单配表。木、火、土、金、水分别联系肝、心、脾、肺、肾，同时贯通风热湿燥寒、酸苦甘辛咸、筋脉肉皮毛骨、目舌口鼻耳及怒喜思忧恐。《五脏生成》《六节藏象论》又以体表荣华和组织所充说明内脏可由外候：心华在面而充在血脉，肺华在毛而充在皮，肝华在爪而充在筋，脾华在唇而充在肌，肾华在发而充在骨。生克关系在病理上表现为疾病传其所胜，在治疗上表现为以相胜关系制约偏亢，但必须结合时令、胃气和实际证候，不能只凭五行名称推断。

五运六气强调环境变化与自稳调节。《五运行大论》认为燥、暑、风、湿、寒、火各以干、蒸、动、润、坚、温发挥作用；一气太过，会制其所胜并反侮所不胜，一气不及，则受所不胜之乘侮。《六微旨大论》以“亢则害，承乃制”说明系统内部存在制约机制；又以升、降、出、入概括一切生命活动，四者停止便意味着神机、气立和生长化收藏的终止。

《五常政大论》提出不同地域气候可致相似病证而治法不同，并规定毒药治病必须保留余地：大毒之药病去其六，常毒去其七，小毒去其八，无毒去其九，余病以谷肉果菜调养，避免攻邪过度损伤正气。《六元正纪大论》要求用寒药避寒时、用热药避热时，并提出“木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之”，即治疗要顺着各类郁滞的性质解除其势。

《至真要大论》将上述理论落实为病机审查。诸风掉眩多从肝，诸寒收引多从肾，诸湿肿满多从脾，水液清冷多从寒，酸腐呕吐与暴注下迫多从热等，都是“据共同表现追究主导病机”的归类法，不宜倒置为见一症便锁定一脏一邪。原文紧接着要求同时查“有无、盛虚”和五行制胜，正是防止机械套用。

“审察病机，无失气宜。”

PDF 第 27 页（原书第 23 页）

2.2.3 藏象、气血津液与水谷化生

脏腑是协作的功能系统。《灵兰秘典论》以官职比喻十二脏腑：心主神明，肺主治节，肝主谋虑，胆主决断，脾胃司仓廩，小肠受盛化物，大肠传导变化，肾主作强伎巧，三焦决渎水道，膀胱藏津液并赖气化而出。比喻的重点在“不得相失”：心神清明，各官才能协调；主不明则使道闭塞，整体形体受伤。因此藏象不是十二个孤立器官的清单，而是有统摄、有分工、有通道的系统。

《六节藏象论》分别说明心为生之本、肺为气之本、肾为封藏之本、肝为罢极之本，脾胃及肠、三焦、膀胱为仓廩和转输之本，并以“十一脏取决于胆”强调决断、升发或枢机对全身功能的影响。《五脏生成》把五脏与脉、皮、筋、肉、骨及其外荣相联，既用于理解生理，也用于望诊定位。

“藏而不泻”与“泻而不藏”。《五脏别论》区分五脏、传化之腑和奇恒之腑。五脏藏精气，故“满而不能实”；胃、大小肠、三焦、膀胱传化水谷，故“实而不能满”，其内容物必须不断更替；脑、髓、骨、脉、胆、女子胞既似腑而有藏精性质，故称奇恒之腑。胃为水谷之

海，五脏六腑之气皆借胃气显于气口，这也解释了后文为什么脉诊反复以“有胃气”为生肌所在。

水谷经中焦化为精微，再由脾肺布散。《经别论》分别描写食与饮的输布。食入胃后，精微散于肝而养筋，浊气归心而入脉，再由肺朝百脉、输精皮毛，最终归于整体权衡；饮入胃后，上输于脾，脾散精归肺，肺通调水道，下输膀胱，使水精四布。这里胃负责受纳，脾负责转输，肺负责宣降通调，膀胱赖气化排泄，肝心参与营养筋脉，构成连续链条。

《太阴阳明论》进一步解释脾胃虽以膜相连，功能却有内外、虚实之别。外邪易从阳分入六腑，饮食起居失节易从阴分伤五脏；脾若不能为胃行津液，四肢便失去水谷精气濡养而不用。阳明为五脏六腑之海，足太阴又为三阴转输，因此“治痿独取阳明”的理论在此获得基础。

五味既能养人，也能伤人。《脏气法时论》把脏腑的苦欲与五味的散、收、缓、坚、软联系起来：肝苦急而喜缓散，肺苦上逆而欲收，肾苦燥而需润等。补泻不能只按味的固定标签，而应看该脏当下所苦所欲。《宣明五气》则提出五味所禁和五劳所伤，如气病慎辛、血病慎咸，久视伤血、久卧伤气、久坐伤肉、久立伤骨、久行伤筋。饮食结构上以五谷为养、五果为助、五畜为益、五菜为充，体现“药治其偏，食养其正”。

水液病以肾为本，并须联系肺与气化。《水热穴论》说明肾为水脏和胃之关，关门不利则水聚，上下溢于皮肤形成浮肿；其本在肾，末在肺。劳甚使肾汗外出，又遇风而内外俱不得通，可形成风水。临床上不能见水肿便只利小便，还须考察肾的封藏、肺的通调、腠理开阖及劳倦汗出史。

2.2.4 病因、病机与传变

外邪、内伤和“不内外因”共同致病。《生气通天论》《通评虚实论》《调经论》等将风雨寒暑视为外来因素，将饮食居处、喜怒不节视为内伤因素，又把劳倦、跌仆、房劳、膏粱厚味等纳入具体病史。外邪通常先客皮肤，继入孙脉、络脉、大经；内伤则可使脏气直接失守。病因只是起点，能否成病仍取决于正气、体质和受邪部位。

《通评虚实论》以“邪气盛则实，精气夺则虚”给出虚实总纲。实不是所有强烈症状，虚也不是所有慢性症状；必须分清是邪气壅盛，还是正气、精血、津液被夺。肥贵者的消瘠、偏枯、痿厥等可与膏粱相关，暴忧可致上下隔塞，寒风湿可致跛蹇，提示生活方式和社会处境本身就是病机线索。

气机失常可由情志、寒热与劳倦触发。《举痛论》先以寒凝解释疼痛：寒入经脉使血涩、脉急，客脉外、脉中、肠胃、冲脉、背俞或厥阴，便形成不同部位、按压反应和牵引方向；得温痛止、拒按或喜按，都反映寒热、深浅及气血壅滞程度。篇末又提出九气病机：怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，热则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。它把情绪和环境刺激转换为可诊治的气机方向，而不是把情志简单视作心理附属现象。

血气不和是多病共同环节。《调经论》说五脏之道皆出经隧，血气不和则百病变化。气血相并可造成一方有余、一方不足；并走于上可致大厥，气返则生，不返则死。风雨所伤可使邪与血气并于分腠而成外实；寒湿可使营血涩、卫气去而显虚。治疗因此按病位分层：

病在脉调血，在血调络，在气调卫，在肉调分肉，在筋骨则取相应层次；左右脉证相反者可用巨刺或缪刺，但前提是九候审察准确。

疾病传变有次序，也可被治疗改变。《玉机真脏论》以五行相胜解释五脏病邪逆传，指出五脏之气必须借胃气到达手太阴；病甚而胃气不能同至，真脏脉独见，表示邪胜精衰，预后不良。《热论》则以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的日次说明寒邪由表入里的可能路径，并区分单经受病与表里两感。两篇共同强调“传变”是趋势而非宿命，早期通其脏脉、及时汗泄或顾护胃气，可以截断进展。

2.2.5 诊法、预后与医学人文

诊断须在稳定条件下四诊合参。《脉要精微论》主张平旦诊脉，因为此时饮食未进、气血未乱，最便于观察基线。切脉动静之外，还要视精明五色、察形体盛衰、听声音、观五脏六腑强弱，以多项证据参伍。长、短、数、大、细、代、涩等脉象分别提示气治、气病、烦热、病进、气少、气衰及血行不畅；颜色须有含蓄润泽，过于暴露、枯槁或混淆黑白长短，则提示精气衰败。头、背、腰、膝、骨分别作为精明、胸中、肾、筋、髓之外府，姿态功能也是预后信息。

“切脉动静而视精明，察五色，观五脏有余不足，六腑强弱，形之盛衰，以此参伍，决死生之分。”

PDF 第 13 页（原书第 9 页）

平脉的关键是胃气与四时相应。《平人氣象论》以医生自身平息校准病人脉搏：一呼脉二动，一吸脉二动，间以太息共约五动为常。脉数、躁、涩或忽疏忽数须结合尺肤、症状判断。四时脉各有弦、钩、软弱、毛、石之象，但都必须“胃微”而和缓；只见脏脉而无胃气则逆。虚里为胃之大络、宗气所聚，其左乳下搏动过强、断绝或横结，也可判断中焦、积聚和宗气盛衰。

《玉机真脏论》把可治与难治归纳为形气是否相得、色泽是否浮润、脉是否顺四时、是否带胃气。五实为脉盛、皮热、腹胀、二便不通、闷瞀；五虚为脉细、皮寒、气少、二便泄利、饮食不入。实者若汗出而二便通，虚者若浆粥能入且泄止，仍有转机，说明预后判断必须观察动态反应。

诊病必须问人事。《示从容论》要求循法守度又能援物比类，不拘死法。《疏五过论》与《征四失论》集中反省医疗错误：不问由贵转贱、由富转贫可漏掉“脱营”“失精”；不问暴乐暴苦、忧恐喜怒、饮食居处、毒物和发病起始，会把精神内伤误作单纯脏腑病；不辨贫富居处、体质勇怯、男女年龄，也会使补泻和治疗强度失宜。这里所谓医学人文并非额外礼仪，而是病因诊断和疗效判断的组成部分。病人厌恶针石、拒绝治疗，或医患之间“标本不得”，都会使正确技术失效。

2.2.6 治则、针药与因人因地制宜

治疗方式须与地域、病位和体质相合。《异法方宜论》以五方生活环境说明疗法来源：东方鱼盐之地多痈疡，宜砭石；西方饮食肥厚、病多生于内，宜毒药；北方寒冷乳食，脏寒满病，宜灸焫；南方湿热、病多挛痹，宜微针；中央地平而湿，居民食杂而少劳，易痿厥寒

热，宜导引按蹻。其要义是同一医学目的可有不同技术路径，选择应根据地理、饮食、体质和病性。

《汤液醪醴论》进一步指出，针石只是“道”的工具。若嗜欲无穷、忧患不止，精坏神去，营卫不能复收，则仅靠技术难愈；治疗水肿一类形体大病时，要平衡攻补，去陈积、动四肢、温衣、缪刺，并“开鬼门、洁净府”，即通过发汗和利小便疏通水道，同时恢复五脏功能。

针刺首重治神、察气与知禁。《宝命全形论》列针刺五要：治神、知养身、知药物真伪、掌握砭针大小、明白脏腑血气诊断。《八正神明论》以“上工救其萌芽”强调在三部九候尚可调时介入。《刺禁论》虽所录甚简，却以肝左、肺右、心表、肾里、脾使、胃市提示刺法必须明辨脏腑位置和功能，避免误伤重要部位。针刺不是局部刺激，而是以神、气、形和解剖禁忌共同约束的技术。

标本先后取决于病势缓急。《标本病传论》规定：一般先病为本、后见为标，但中满、二便不利等急迫症可先治标；病势较轻可标本并治，病势重则集中处理主要矛盾。《至真要大论》又区分正治与反治：寒者热之、热者寒之为常；真寒假热、真热假寒等复杂情况，可采用热因寒用、寒因热用、塞因塞用、通因通用，但必须先识其主病与假象所因。所谓“从治”不是违反阴阳，而是透过表象处理深层病机。

方剂组织以主病药为君，佐君者为臣，应臣者为使；大小制方取决于病情而非药物等级。药有毒无毒，都须以所治为主、适量为度。寒热温凉、汗下补泻和食疗均需避开时令偏盛，最终标准是气血正平而非药力越强越好。

2.2.7 典型病证的辨证框架

热病与温病

《热论》描述六经由表入里的症候序列：太阳头项痛、腰脊强，阳明身热目痛鼻干，少阳胸胁痛耳聋，继而太阴腹满嗌干、少阴口燥舌干而渴、厥阴烦满囊缩。未满三日、邪在三阳可酌汗，入三阴则当通泄，但“两感”表里同病预后险恶。病后强食、食肉或多食可使余热与谷气相搏而复发。《评热病论》用汗、脉、食欲和神志判断正邪胜负：汗出而复热、脉仍躁疾、不能食并狂言，表示精气不胜邪气；劳风则见项背强、目昏、恶风振寒、咳吐青黄脓涕，须从太阳经引邪外出，若脓涕壅塞伤肺则可危。由此可见，汗出本身不是疗效终点，必须与脉静、能食和神志恢复相合；“邪之所凑，其气必虚”是解释重病与复发的总纲。

咳证

《咳论》明确“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。肺合皮毛，最先受外寒，寒饮又可从胃上犯于肺；五脏各随所主时令受邪，久咳再移于相合之腑。肺咳可喘而唾血，心咳兼心痛喉梗，肝咳牵两胁，脾咳引右肋肩背，肾咳牵腰背并多涎；传腑后可见呕、胆汁、遗便、矢气、遗尿或腹满。各种咳最后都与胃气聚集、肺失宣降相关，故辨治须同时看肺、所传脏腑和中焦。

疼痛

《举痛论》以寒凝、热结、气血涩滞解释痛势差异。暴痛得温即止多为浅寒，重寒则痛久；脉满拒按多属壅实，按之痛减提示气血得散；背俞、冲脉、厥阴、小肠膜原受邪分别可形成心背相引、腹部动应手、胁少腹牵痛和久积。末段以九气病机补足情志与

劳倦所致疼痛、呕逆、泄泻和闭结。

风病与痹证

《风论》说风“善行而数变”，故病位游走、变化迅速。《痹论》则以风寒湿三气杂合说明行痹、痛痹、着痹；依受邪季节和所合组织，可由皮、肌、脉、筋、骨逐步内舍肺、脾、心、肝、肾。入脏者危，留筋骨者缠绵，留皮肤者较易愈。疼痛、不仁、寒、热、多汗分别反映寒多、病深营卫涩、阴阳偏盛和湿盛。针治须循五脏俞、六腑合及病脉所过，而不是只刺痛点。

痿证

《痿论》以肺热叶焦、心热伤脉、肝热筋干、脾热肌肉失养、肾热骨枯髓减分为痿躄、脉痿、筋痿、肉痿、骨痿，并追溯悲哀、所愿不得、房劳、湿地久居、远行劳倦逢大热等病因。五脏虽各有病机，治疗仍重阳明，因为阳明为五脏六腑之海，冲脉又与阳明会于宗筋；阳明确则宗筋纵、带脉不引，足痿不用。故治法为补相应荥穴、通俞穴、调虚实逆顺，同时顾护胃气。

水肿

《水热穴论》把肾之关门、肺之通调与皮肤玄府联系起来。水聚皮下而成脓肿，或劳汗当风形成风水，均须辨其本在肾、标在肺与皮肤。该病证与《汤液醪醴论》的“开鬼门、洁净府”互相发明：治疗既可由汗解表，也可由小便分消，但必须顾正气和恢复气化。

2.3 《灵枢》：经络针刺与精气神的运行结构

2.3.1 针刺、经络与脏腑联络

针刺疗效以“气至”为枢纽。《九针十二原》没有把针刺效果归于机械深浅，而以经气是否到达作为判断：

“刺之要，气至而有效，效之信，若风之吹云，明乎若见苍天。”

PDF 第 30 页（原书第 26 页）

“气至”意味着针刺已使局部与整体气机发生可观察变化，故必须结合病人感觉、医者手下变化和症候反应判断。《刺节真邪》又说真气受于天，并与谷气合而充身；针刺调动的不是孤立穴位，而是先天禀赋与后天水谷共同形成的正气。《九宫八风》要求候虚风而避之，说明针刺疗效也受时空环境与外邪暴露影响。

脏腑表里是经脉网络的内在配对。《本输》列肺合大肠、心合小肠、肝合胆、脾合胃、肾合膀胱。三焦主水道而属膀胱系统，被称为“孤府”；少阴肾又上连肺，水液代谢因此不能只看下焦。表里配对既解释病证互传，也为取穴、诊脉和调水道提供依据。

十二经脉构成有方向的闭合通路。《经脉》先说明精成而脑髓生，骨、脉、筋、肉、皮肤依次构成人体支架与屏障；谷入于胃后，脉道通而血气行。因此经脉的功能是决死生、处百病、调虚实。所录十二经路径可以按方向把握：

1. 手三阴由胸走手。手太阴肺经起中焦，下络大肠、还胃口、属肺，沿上肢内前侧至拇指；手少阴心经起心中，联系心系、小肠、咽与目系，沿上肢内后侧至小指；手厥阴

心包经起胸中，属心包并下络三焦，沿两筋之间至中指，支脉至无名指。三者把胸中脏器与上肢末端联结。

2. 手三阳由手走头。手阳明大肠经由食指上行，过肩缺盆后络肺属大肠，支脉上颈入下齿并挟鼻；手太阳小肠经由小指沿臂后外侧上肩，络心属小肠，支脉联系颊、目、耳、鼻；手少阳三焦经由无名指沿臂外侧上肩，布膻中、络心包、属三焦，再上项绕耳至目外眦。
3. 足三阳由头走足。足阳明胃经从鼻面下行，联系齿、口、咽、胃脾，再经胸腹、髀膝至足趾；足太阳膀胱经从目内眦上头入脑，出项后挟脊下行，络肾属膀胱，沿下肢后侧至小趾；足少阳胆经从目外眦绕头耳，下缺盆、络肝属胆，再循胁髀和下肢外侧至第四趾，并有支脉入大趾。三者把头面感觉、躯干脏腑和下肢运动贯通。
4. 足三阴由足走腹胸。足太阴脾经从大趾内侧上行，属脾络胃，过膈挟咽、连舌根，支脉注心中；足少阴肾经由足心、内踝、脊柱入肾络膀胱，上贯肝膈入肺、挟舌本，支脉络心；足厥阴肝经由大趾上行，过阴器抵少腹，属肝络胆，上贯膈、布胁肋、连目系并会督脉于巅，支脉复上注肺。

十二经不是十二条互不相干的线，而以脏腑表里、手足交接、头胸腹支脉和循环方向相互接续。经脉循行还直接规定症候定位，例如足厥阴受病可见腰痛不能俯仰、胁满、疝、遗溺或闭癃，说明“循行所过”与“所生病”必须合参。选文又区别经与络：经脉深行分肉，平时不可见，其虚实多由气口得知；浮现于体表者多是络脉，饮酒或邪气停居可使络脉先盛。临床观察某一络脉突然充盈、坚陷或与众不同，可反推邪气停留的本末部位。

2.3.2 精、神、魂、魄与个体差异

精神活动有从生命本原到认知决策的层次。《本神》先以“天之在我者德，地之在我者气”说明生命由自然禀赋与形质之气相合而生，再把精、神、魂、魄、心、意、志、思、虑、智连成连续过程：父母两精相合而成形，生命活动显为神；魂随神往来，魄并精出入；心任物，忆而成意，意之所存为志，志的变化为思，思及远处为虑，依虑处物为智。这不是把精神现象拆成孤立实体，而是说明感知、记忆、目标、思考和决断怎样建立在精气和脏腑之上。

过度思虑、悲哀、喜乐、忧愁、盛怒、恐惧，分别可使神散、气闭、魂魄失守或精伤；五脏虚实又出现相应的情志与躯体表现。篇末强调针者须先察精、神、魂、魄存亡，若五者严重受伤，单靠针刺不能挽回。这与《素问》“神不使”相互印证：治疗能力有边界，精神状态和正气基础决定技术是否还能起效。

体质不同，治疗反应便不同。《寿夭刚柔》指出人生有刚柔、强弱、长短、阴阳之别，是一切因人制宜的前提。《通天》把人分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平五型，强调其形态、筋骨、气血不等；《阴阳二十五人》又以五为基本结构扩展体质分类。所选文字未详列每型的全部诊候，故应把握其原则：体质分类用于预测易感、耐受和针刺反应，不宜据标签替代实际诊察。

《天年》说明父母为形体根基，血气和、营卫通、五脏成、神舍于心、魂魄具，方成为完整的人；“得神者生，失神者死”把神色、反应与生命预后直接相联。《阴阳系日月》所言阴阳“有名而无形”，则提醒阴阳和体质类型都是解释关系的概念，不能误当作可直接割取的实体。

2.3.3 营卫、精气血津液与三焦

营行脉中，卫行脉外。《营卫生会》说人受气于谷，清者为营、浊者为卫。营随经脉周流，卫气慄疾滑利、运行于皮肤分肉；二者相贯如环，昼夜各有阴阳二十五度的节律。壮年气血盛、肌肉滑、气道通，故昼精夜眠；老年气血衰、气道涩，营少而卫气内扰，故白昼不精、夜间不寐。睡眠在这里是营卫能否按时出入阴阳的结果。

中焦泌糟粕、蒸津液，把精微上注肺脉而化血；上焦宣散如雾，下焦排泄如渫，故有“上焦如雾，中焦如沤，下焦如渫”的功能分区。夺血者不可再强发汗，夺汗者不可再耗血，因为血与汗都来自水谷精微，过度损伤任何一方都可能危及生命。

精、气、津、液、血、脉同源而分工。《决气》逐项界定六者：精先身而生，是形体根本；气由上焦宣发，熏肤泽毛；津质清而流动，随腠理外泄为汗；液质稠而濡养关节、脑髓和皮肤；血由中焦取汁、变化而赤；脉约束营气使其按道运行。六者同出水谷与先天之精，却因部位、形态和功能而异名。

其脱失证候具有鉴别意义：精脱耳聋，气脱目不明，津脱腠开而大汗，液脱则关节屈伸不利、脑髓消减、胫酸耳鸣，血脱则面色白而不泽、脉空虚。《口问》从上、中、下三部补充气不足的表现：上气不足见脑不满、耳鸣、头倾、目眩；中气不足见二便改变、肠鸣；下气不足见痿厥与心中烦闷。诊断时应辨所亏物质和所在部位，而不能把“虚”一概而论。

《本脏》将血气精神、经脉、卫气、志意、寒温统合起来：血和则经脉流行、筋骨强、关节利；卫和则分肉解利、皮肤柔、腠理密；志意和则精神专、魂魄不散；寒温和则六腑化谷、经脉通、风痹不作。这是《灵枢》对“常平状态”的完整定义。

2.3.4 病因、诊候与典型病证

正虚是邪气着落的条件。《邪气脏腑病形》列情志、寒饮、跌仆瘀血、大怒、醉后房劳、汗出当风、举重和浴水等伤脏路径。《百病始生》把喜怒不节归于伤脏而病起于阴，风雨伤上，清湿伤下；但外邪不能凭空致病，只有虚邪之风与形体之虚“两虚相得”，邪才客于形。由天时、体质、受邪部位三者合参，才能说明大病为何在某人、某处形成。

“风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人。”

PDF 第 37 页（原书第 33 页）

《顺气一日分为四时》把一天比作四季：晨如春，人气始生，病势多减；日中如夏，人气长而较安；日入如秋，人气衰而病加；夜半如冬，人气入藏而邪相对独盛。若病势不合此规律，则应考虑某脏独主其病，并以该脏所不胜之时加重、所胜之时减轻来解释。治疗既要识病，也要选时。

五色望诊判断病位、深浅和成败。《五色》以沉浊主内、浮泽主外，黄赤多风，青黑多痛，白多寒；黄而膏润可见脓，赤甚可见血。观察不仅是认颜色，还要看浮沉以定浅深、润枯以定成败、散抟以定远近、上下以定病处。与《脉要精微论》合看，色诊必须重光泽、层次和动态，不可只凭单一色名断病，是否兼热仍须合参其他证候。

水肿诸证重在触诊和月经鉴别。《水胀》区分水、肤胀、鼓胀、肠覃、石瘕。水病初起可见眼睑微肿、颈脉动、咳、阴股寒、足胫肿，腹按后随手复起如裹水；肤胀是寒客皮肤，

腹大身肿、皮厚，按之凹陷不即起而肤色不变；鼓胀与肤胀形似，但色苍黄、腹壁脉络显露。肠覃为寒客肠外、与卫气相搏，肿块坚而可移，月经仍按时；石瘕生于胞中，寒闭子门、恶血留止，肿块日大而月经失期。后二者以肿块活动度和月经是否正常为关键鉴别。

危急证看汗脉、肢冷和神志。《热病》以汗后脉静为正胜，汗后脉仍躁盛为阴脉之极；脉躁而不得汗为阳脉之极，均属危候。《厥病》所说真头痛，痛连脑髓而手足寒至关节；真心痛，心痛剧烈且四肢青冷至关节，均预后极差，提示中枢剧痛伴末梢厥冷是危重组合。原文又告诫心中有盛聚者不可妄刺。

失眠与目系体现营卫和五脏精气的上达。《邪客》认为厥气客于五脏六腑，卫气便独行于阳而不能入阴，阳跷偏盛、阴分不足，故目不瞑。治疗为补不足、泻有余、通其道路；所载半夏秫米汤以和胃交通阴阳，病新者可很快入睡，久病则需渐调。这里的方药不是单纯镇静，而是调整胃、营卫和阴阳出入。

《大惑论》说明五脏六腑精气皆上注于目：瞳子、黑睛、血络、白睛、眼睑约束分别与骨、筋、血、气、肌肉之精相关，诸精合而为目系，上属脑、后出项中。眼既是局部感觉器官，也是五脏精气、经脉和脑联系的窗口。

“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。”

PDF 第 39 页（原书第 35 页）

2.4 跨篇整合：一套可操作的临床思维

将《素问》的理论与《灵枢》的运行结构合并，可形成如下诊疗次序：

1. 建立正常参照。问年龄、性别、体质、季节、昼夜、地域、饮食、劳逸和社会处境；以平人呼吸、胃气、四时脉色作为比较基线。
2. 定位病所。分表里、上下、内外、脏腑、经络、营卫、气血津液及筋骨肌肉皮毛；结合疼痛牵引、颜色浮沉、脉象和功能障碍判断层次。
3. 辨认病性。查寒热、燥湿、风火，分正邪、虚实、阴阳偏胜，并观察升降出入是逆、陷、闭、越还是耗散。
4. 推断来源与传变。追问外邪、饮食、情志、房劳、劳倦、跌仆和治疗经过，判断由外入内、由脏传腑、由经入络或五行相胜传变的可能方向。
5. 确定先后缓急。急迫中满、二便不利或危重神昏可先治标；一般病程重在治本。病轻可标本兼顾，病重则集中处理主导病机。
6. 选法并控制强度。针灸药食、汗吐下和导引各因地、因人、因时而用；虚者补、实者泻，寒热真假复杂时才用反治。始终顾护胃气、精气和神志。
7. 以反应复核判断。汗后脉是否转静，进食与二便是否恢复，色泽是否转润，痛是否随温按变化，睡眠和精神是否改善，都是重新判断正邪胜负的依据。

因此，《内经》的“辨证”不是给症状贴标签，而是反复完成“比较常态、定位层次、解释机制、预测传变、选择干预、观察反馈”的闭环。

2.5 所选篇章覆盖索引

以下索引按原文出现顺序列出本笔记所覆盖的全部篇章，并标明其在上述体系中的主要作用。

2.5.1 《素问》选篇

《上古天真论篇第一》

PDF 第 5 页（原书第 1 页）。论形神合一、肾气与天癸的男女生命节律，并以节欲、节劳、调起居说明养生。

《四气调神大论篇第二》

PDF 第 6 页（原书第 2 页）。以生、长、收、藏统摄四时作息情志，提出治未病。

《生气通天论篇第三》

PDF 第 6 至 7 页（原书第 2 至 3 页）。论阳气卫外、昼夜开阖、外邪内伤及阴平阳秘。

《金匱真言论篇第四》

PDF 第 8 页（原书第 4 页）。以藏精防温病，连接冬藏与春病。

《阴阳应象大论篇第五》

PDF 第 8 至 10 页（原书第 4 至 6 页）。建立阴阳、五行、五脏五体五窍、病机、诊法与治则总纲。

《阴阳离合论篇第六》

PDF 第 10 页（原书第 6 页）。说明阴阳可无限分化而总要归一。

《灵兰秘典论篇第八》

PDF 第 10 页（原书第 6 页）。以十二官比喻脏腑分工和心神统摄。

《六节藏象论篇第九》

PDF 第 10 至 11 页（原书第 6 至 7 页）。论五气五味养脏、五脏功能根本及季节联系。

《五脏生成篇第十》

PDF 第 11 页（原书第 7 页）。说明五脏与脉皮筋肉骨及外荣的对应。

《五脏别论篇第十一》

PDF 第 11 页（原书第 7 页）。区分五脏、传化之腑、奇恒之腑，并确立胃气与气口关系。

《异法方宜论篇第十二》

PDF 第 11 至 12 页（原书第 7 至 8 页）。按五方环境、饮食和病性配置砭、药、灸、针、导引。

《汤液醪醴论篇第十四》

PDF 第 12 页（原书第 8 页）。论神不使、医患标本及水病的综合疏治。

《脉要精微论篇第十七》

PDF 第 12 至 13 页（原书第 8 至 9 页）。规定平旦诊脉、四诊参伍、色脉形神与死生判断。

《平人氣象论篇第十八》

PDF 第 13 至 14 页（原书第 9 至 10 页）。以呼吸定平脉，以胃气和四时脉判断顺逆。

《玉机真脏论篇第十九》

PDF 第 14 至 15 页（原书第 10 至 11 页）。论五脏逆传、真脏脉、四难及五虚五实的转机。

《经脉别论篇第二十一》

PDF 第 15 页（原书第 11 页）。论勇怯体质、水谷精微输布及肺朝百脉、脾肺行水。

《脏气法时论篇第二十二》

PDF 第 15 至 16 页（原书第 11 至 12 页）。依四时脏气苦欲运用五味补泻。

《宣明五气篇第二十三》

PDF 第 16 页（原书第 12 页）。列五味禁忌与久视、久卧、久坐、久立、久行之劳伤。

《宝命全形论篇第二十五》

PDF 第 16 页（原书第 12 页）。提出针刺治神、养身、药物、针具和诊察五要。

《八正神明论篇第二十六》

PDF 第 16 页（原书第 12 页）。以上工救萌芽强调早诊早治和三部九候。

《通评虚实论篇第二十八》

PDF 第 17 页（原书第 13 页）。以正邪界定虚实，并联系膏粱、忧伤、风寒湿等病因。

《太阴阳明论篇第二十九》

PDF 第 17 页（原书第 13 页）。阐明脾胃表里、内外受邪、津液转输和四肢失养。

《热论篇第三十一》

PDF 第 18 页（原书第 14 页）。描述六经热病次序、两感危候、汗泄时机与病后食复。

《评热病论篇第三十三》

PDF 第 19 页（原书第 15 页）。以汗、脉、食欲、神志判断阴阳交与劳风预后。

《咳论篇第三十八》

PDF 第 19 至 20 页（原书第 15 至 16 页）。论五脏六腑皆可致咳及久咳传腑。

《举痛论篇第三十九》

PDF 第 20 至 21 页（原书第 16 至 17 页）。以寒凝和九气说明痛势、按压反应、牵引部位及气机变化。

《风论篇第四十二》

PDF 第 21 页（原书第 17 页）。概括风邪善行数变、为百病之长。

《痹论篇第四十三》

PDF 第 21 至 22 页（原书第 17 至 18 页）。分行、痛、着痹及五体五脏传变，说明营卫、寒热、不仁和针治。

《痿论篇第四十四》

PDF 第 23 页（原书第 19 页）。分五脏痿证，追溯情志、房劳、湿热和劳倦，并说明治痿取阳明。

《刺禁论篇第五十二》

PDF 第 23 页（原书第 19 页）。提示脏腑所在、表里和针刺禁慎。

《水热穴论篇第六十一》

PDF 第 24 页 (原书第 20 页)。以肾为水之本、肺为其末, 解释肘肿与风水。

《调经论篇第六十二》

PDF 第 24 至 25 页 (原书第 20 至 21 页)。论经隧行血气、气血相并、内外虚实和分层针治。

《标本病传论篇第六十五》

PDF 第 25 页 (原书第 21 页)。规定标本先后、缓急和兼治原则。

《五运行大论篇第六十七》

PDF 第 25 至 26 页 (原书第 21 至 22 页)。论六气作用及太过不及的乘侮。

《六微旨大论篇第六十八》

PDF 第 26 页 (原书第 22 页)。以亢害承制和升降出入说明生化常变。

《五常政大论篇第七十》

PDF 第 26 页 (原书第 22 页)。论同病异治、毒药剂度、食养和不可违时。

《六元正纪大论篇第七十一》

PDF 第 26 至 27 页 (原书第 22 至 23 页)。论六气偏胜、用药避时和五郁治法。

《至真要大论篇第七十四》

PDF 第 27 至 28 页 (原书第 23 至 24 页)。集中论病机十九条、正治反治、内外先后、方剂君臣使及调气制方。

《示从容论篇第七十六》

PDF 第 28 页 (原书第 24 页)。要求循法守度而能援物比类。

《疏五过论篇第七十七》

PDF 第 28 至 29 页 (原书第 24 至 25 页)。从社会变迁、情志、学术、体质与病史反省五种医疗过失。

《征四失论篇第七十八》

PDF 第 29 页 (原书第 25 页)。批评不辨阴阳、学术不精、不察贫富体质、不问病始的四失。

2.5.2 《灵枢》选篇

《九针十二原第一》

PDF 第 30 页 (原书第 26 页)。以气至为针刺见效的核心标志。

《本输第二》

PDF 第 30 页 (原书第 26 页)。说明五脏六腑表里相合及三焦水道地位。

《邪气脏腑病形第四》

PDF 第 30 页 (原书第 26 页)。列情志、寒饮、跌仆、房劳、汗风和劳力伤脏路径。

《寿夭刚柔第六》

PDF 第 30 页 (原书第 26 页)。确立刚柔强弱、长短阴阳的体质差异。

《本神第八》

PDF 第 30 至 31 页 (原书第 26 至 27 页)。系统定义精、神、魂、魄、心意志思虑智,

并论情志伤脏和治神边界。

《经脉第十》

PDF 第 31 至 33 页（原书第 27 至 29 页）。论经脉功能、十二经循行、脏腑联络及经络可见性的差别。

《营卫生会第十八》

PDF 第 33 至 34 页（原书第 29 至 30 页）。论营卫来源、脉内脉外、昼夜五十周及三焦化生。

《热病第二十三》

PDF 第 34 页（原书第 30 页）。以汗后脉静或躁判断正邪与生死。

《厥病第二十四》

PDF 第 34 页（原书第 30 页）。提出真头痛、真心痛及不可妄刺的危候。

《口问第二十八》

PDF 第 34 至 35 页（原书第 30 至 31 页）。分上、中、下气不足及相应耳目、二便、痿厥表现。

《决气第三十》

PDF 第 35 页（原书第 31 页）。辨精、气、津、液、血、脉及各自脱失证候。

《阴阳系日月第四十一》

PDF 第 35 页（原书第 31 页）。指出阴阳为有名无形的关系范畴。

《顺气一日分为四时第四十四》

PDF 第 35 至 36 页（原书第 31 至 32 页）。以一日配四时解释病势旦慧昼安、夕加夜甚及其反常。

《本脏第四十七》

PDF 第 36 页（原书第 32 页）。定义血、经脉、卫气、志意与寒温协调的常平状态。

《五色第四十九》

PDF 第 36 页（原书第 32 页）。以五色浮沉、润枯、散抟、上下判断表里、深浅、病位和成败。

《天年第五十四》

PDF 第 36 页（原书第 32 页）。说明父母形基、营卫五脏与神魂共同成就生命。

《水胀第五十七》

PDF 第 36 至 37 页（原书第 32 至 33 页）。鉴别水、肤胀、鼓胀、肠覃和石瘕。

《阴阳二十五人第六十四》

PDF 第 37 页（原书第 33 页）。以五类结构说明人体禀赋与天地相应。

《百病始生第六十六》

PDF 第 37 页（原书第 33 页）。论三部受邪、两虚相得和病名随邪所舍而立。

《邪客第七十一》

PDF 第 38 页（原书第 34 页）。以卫气不得入阴解释失眠，并载半夏秫米汤交通阴阳。

《通天第七十二》

PDF 第 38 页（原书第 34 页）。提出五类体质的形态、筋骨和气血差异。

《刺节真邪第七十五》

PDF 第 38 页（原书第 34 页）。说明真气由先天之气与谷气合充全身。

《九宫八风第七十七》

PDF 第 38 页（原书第 34 页）。强调候避虚风、预防外邪。

《大惑论第八十》

PDF 第 39 页（原书第 35 页）。论五脏六腑精气上注于目及目系上属脑、后出项中。

2.6 校勘说明

- 分页文本的 PDF 页码与页内原书页码相差四页，故本笔记统一写作“PDF 第 X 页（原书第 Y 页）”。引用均按页面所见文字核对。
- PDF 第 14 页（原书第 10 页）OCR 将《平人氣象論》的“长夏胃微软弱曰平”误作“长夏胃微耍弱曰平”，并将“而稟有石曰冬病”误作“面稟有石曰冬病”。正文按页面影像改为“软弱”，但保留“稟”所表达的柔软义，不据此扩大解释。
- PDF 第 17 页（原书第 13 页）“内内气暴薄”“不从内内”有明显重复误识，结合句法分别按“内气暴薄”“不从内外”理解；同页“筋骨肌内”按语义校作“筋骨肌肉”。
- PDF 第 23 页（原书第 19 页）“主润宗筋”按通行语义校作“主润宗筋”；“摠”作为“总”的异体字，在笔记中统一写作“总”。
- PDF 第 27 页（原书第 23 页）“诸气（缺字）郁”中的缺字在原文件中未显示；据《素问·至真要大论》通行文本可校为“膹”，故正文采用“诸气膹郁”，同时保留原 PDF 字形缺失的校勘说明。
- PDF 第 31 至 33 页（原书第 27 至 29 页）《本神》《经脉》有若干黑方块，部分对应罕见古字或缺字。可由经脉上下文确认者，正文改写为现代部位名称，如“鼻根”“颧部”“疝”；不能确认者不作逐字引文。
- PDF 第 32 页（原书第 28 页）“历络三（缺字）”依经脉上下文应为“历络三焦”；PDF 第 34 页（原书第 30 页）“阳陇”“阴陇”按文义统一作“阳隆”“阴隆”。
- “荣卫”与“营卫”、“写”与“泻”、“肘肿”等在古籍及本 PDF 中存在异体或版本用字。笔记叙述统一采用现代常用的“营卫”“泻”，篇义专名“肘肿”保留；直接引文则尽量从原页。
- PDF 第 39 页（原书第 35 页）在本节只收入《大惑论第八十》关于目系的一段；同页其后的《伤寒论篇》未纳入《内经》本节笔记，也未用于本节归纳。

3、《伤寒论》六经辨证精读

3.1 六经辨证的总框架

3.1.1 六经不是六个固定病期

六经是对外感病过程中病位、病性、正邪盛衰及其变化趋势的综合分类。太阳主表，阳明主里实，少阳主半表半里；太阴以脾阳虚、寒湿内盛为核心，少阴以心肾阳气或阴液衰损为核心，厥阴则多见阴阳不相顺接以及寒热错杂。它们可以依次传变，也可以越经、直中、合病、并病，更可因误汗、误下、误吐、火劫而形成坏病。因此，辨证的次序应是先辨表里、寒热、虚实，再核对六经提纲和方证，不能仅按患病日数机械套经。

太阳初病，脉象安静而无呕、烦躁、数急，为邪势未传；出现欲吐、烦躁、脉数急，提示可能传变。二三日仍不见阳明、少阳证，也可判断未传。所谓一日太阳、二日阳明，只是常见趋势，不是日程表。原文提出：

“伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦脉数急者，为传也。”(PDF 第 39 页，原书第 35 页)

传变的动力主要有三类：一是邪盛而正不能拒，太阳表邪入里；二是体质偏颇，如阳旺津亏者易从热化入阳明，阳虚者易直中三阴；三是治疗失当，尤其误汗伤阳津、误下使邪内陷、火劫耗伤血津。故《伤寒论》的临床核心不是追问“传到第几经”，而是判断此刻何处有邪、何处已虚、何法可承受。

3.1.2 总治则与先后缓急

1. 有表先解表，但里急先救里。表未解而里证不急，一般先解表后治里；若下利清谷、脉微欲绝、四肢厥逆，则阳亡在即，须先以四逆汤类救里，里和以后再用桂枝汤小和其表。太阳篇第 91 条、厥阴篇第 372 条、霍乱篇第 387-390 条相互发明。
2. 实则攻邪，虚则扶正，虚实夹杂则和解或寒热并用。阳明燥实方可承气；少阳枢机不利用柴胡剂和解；太阴、少阴虚寒多温补；厥阴寒热错杂则乌梅丸、干姜黄连黄芩人参汤等寒温并投。
3. 汗法以“微似汗”为度。桂枝汤服后啜热稀粥、温覆，取遍身微汗，严禁汗如水流。麻黄、大青龙等峻汗方也须中病即止。汗多可亡阳、伤津、动悸、成水饮，甚至厥逆。
4. 下法必须有里实依据。潮热、手足濇然汗出、腹满硬痛、燥屎、转矢气等为可下线索；呕多、心下硬满而无燥实、外证未解、津液枯竭、脉微涩者禁下。攻下后须观察“得下则止”，不可连投。
5. 顾护胃气与津液。汗、吐、下以及利小便均能伤津。大病后强食亦会使脾胃不胜而烦。全篇反复以能食与否、口渴、小便、大便、汗出和脉势判断胃气存亡。
6. 动态辨证，随证救逆。“观其脉证，知犯何逆，随证治之”(PDF 第 40 页，原书第 36 页)是坏病处理总纲。方名相同不等于病机相同，必须结合治疗史、表里状态和正气强弱。

3.2 太阳病：表证、兼证及误治变证

3.2.1 提纲与三类初起病证

太阳病提纲为“脉浮，头项强痛而恶寒”（PDF 第 39 页，原书第 35 页）。恶寒是表证尚在的重要标志，脉浮反映正邪相争于表。初起须分三型：

- 太阳中风：发热、汗出、恶风、脉缓，属卫强营弱、营卫不和，治以解肌调营卫，主方桂枝汤。
- 太阳伤寒：或已发热或未发热，必恶寒，兼体痛、呕逆、脉阴阳俱紧，属寒束肌表、卫闭营郁，治以辛温发汗，主方麻黄汤。
- 温病：发热而渴、不恶寒，病初即有里热伤津倾向，禁用辛温强汗。若误汗而身灼热、自汗、身重嗜睡、鼾息、语言难出，成为风温；再误下可小便不利、直视失溲，误火可发黄、惊痫、瘕瘕，属连续逆治，预后险恶。

第 7 条以“发热恶寒”与“无热恶寒”概括病发于阳、病发于阴；第 11 条又用患者欲近衣与否辨真寒假热、真热假寒，提示外观冷热不等于内在病性。太阳头痛七日以上自愈、风家表解后十二日渐愈，说明正复邪退有其自然病程；无传变证时不必过度干预。

3.2.2 太阳表证高频方证

桂枝汤

证机为营卫不和。主症是发热、汗出、恶风、头痛、鼻鸣、干呕、脉浮缓。治以解肌发表、调和营卫。辨别点是“有汗而表不解”，并非见汗即禁汗。常自汗或定时发热自汗，也可用桂枝汤调营卫。下后仍见气上冲，说明表邪尚有外出之势，可以再用；若不气上冲，则不可机械回用。

桂枝加葛根汤

桂枝证兼项背强几几、汗出恶风，以葛根舒筋生津。节录本方下列有麻黄，但注文已指出与“汗出恶风”不合，疑应为桂枝汤原方只加葛根，详见校勘说明。

葛根汤

无汗、恶风、项背强几几，为太阳伤寒兼经输不利；太阳、阳明合病而自下利，也以葛根升津舒经、麻桂解表。兼呕者加半夏、生姜，即葛根加半夏汤。

麻黄汤

头痛发热、身腰骨节俱痛、恶风、无汗而喘、脉浮紧，属风寒束表。太阳阳明合病见喘而胸满，外束未解，不可因胸满误下。病十日后若脉仅浮、表证仍在，仍可用；若脉浮细而嗜卧，外已解，不可再汗。

桂枝加厚朴杏子汤

桂枝证素有喘，或误下后表未解而微喘。它以调和营卫为本，厚朴、杏仁降肺气；与麻黄汤的无汗实喘、麻杏甘石汤的汗出热喘不同。

大青龙汤

表寒闭郁较重而里有烦热：脉浮紧、身痛无汗、烦躁；或脉浮缓、身重乍轻且无少阴证。麻黄用量重，并配石膏清郁热。若脉微弱、汗出恶风，本属表虚，严禁使用；误服可大汗亡阳，出现厥逆、筋惕肉瞤。

小青龙汤

表寒不解兼心下水饮，见干呕、发热、咳喘，并可有渴、下利、噎、小便不利、少腹满。麻桂解表，干姜、细辛、半夏温化水饮，五味子敛肺。服后反渴，是寒饮已去、津气将复，常为欲解，不宜误判为药不效。

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤

太阳病迁延、发热恶寒如疟，热多寒少、表郁不甚，属桂麻合方小剂发汗。面有热色、身痒提示邪郁肌表而不得小汗；若脉微而恶寒，则阴阳俱虚，汗吐下皆禁。

桂枝二越婢一汤

热多寒少兼轻度郁热而表闭不甚，取桂枝汤调营卫，少佐越婢汤疏表清热。第 27 条“脉微弱、无阳、不可发汗”与方后用麻黄、石膏文字有解释争议，应理解为不可峻汗，仅宜小剂疏解，不能据此用于典型亡阳证。

服桂枝汤初反烦而不解，可先刺风池、风府，再服原方；服后大汗而脉洪大，如仍是桂枝证，可仍按原法，不可只见“洪大”便改清下。大汗后转为大烦渴、脉洪大，则津伤热盛，改用白虎加人参汤。麻黄汤后烦、目瞑甚至鼻衄，是阳郁外达、邪随血泄，衄后可解；自衄而表解者也不必追汗。

桂枝汤虽为太阳中风主方，也有明确禁忌。脉浮紧、发热无汗是麻黄汤证，不可误投；酒客湿热内蕴而不耐甘温，服后易呕。若服桂枝汤即吐，原文警示其后可能吐衄血，提示胃气上逆或内有郁热，必须停药重辨，不能以“未得汗”为由反复强服。

3.2.3 汗法、下法的边界

二阳并病时，若太阳证未罢而仅汗出不彻，不可急下，应小发其汗；面赤、烦躁、痛处游走、短气、脉涩，均可由汗不彻、阳气怫郁所致。相反，脉浮数而尺微、下后身重心悸，或脉浮紧而尺中迟，均提示里虚、营血不足，不可发汗，须待津液与表里自和。汗吐下或亡血、亡津后，阴阳能自行恢复者即可自愈；大下又汗致小便不利，是津液暂亏，勿再利水，待津复则小便自利。

太阳病不大便兼头痛发热，不能只凭便秘投承气。若小便清，说明热不在里而表证仍在，应解表；这是“辨小便以审里热”的范例。太阳表证未解而反复攻下，可致协热下利、心下痞硬；若表里俱不解，用桂枝人参汤温中止利兼解表。若里虚下利清谷而仍身痛，先四逆汤救里，清便自调后再桂枝汤救表。

咽干、淋家、疮家、衄家、亡血家、汗家均属发汗禁忌：误汗可分别加重津伤、便血、疮病、目系拘急失眠、寒栗、神乱阴疼。胃中有寒者误汗，还可吐蛔。禁汗不是绝对拒绝解表，而是强调先评估津血、阳气和既往失治。

重发汗后若两耳无闻，令其试咳亦不能咳，是阳气与清窍之气俱虚，不可再汗。汗家重汗后恍惚心乱、小便后阴部疼痛，节录本仅言“与禹余粮丸”而未载方，治意偏向固涩救脱；因方证资料不全，不能据丸名自行配药。

3.2.4 误汗、误下后的虚证与水气证

甘草干姜汤、芍药甘草汤、调胃承气汤、四逆汤的连续救治

第 29 条先见自汗、小便数、心烦、微恶寒、脚挛急，误投桂枝攻表后厥、咽干、烦躁、吐逆。先用甘草干姜汤复阳；足温而挛急未解，用芍药甘草汤酸甘养阴舒筋；胃不和谵语，仅少与调胃承气汤；若又重汗、烧针而阳衰，则四逆汤回阳。这一条说明同一

病程可由阴阳两伤转为胃实或亡阳，方随证转。

桂枝加附子汤

发汗太过、漏汗不止，恶风、小便难、四肢微急难屈伸，是表阳与津液俱伤，以桂枝汤调营卫，加炮附子固护阳气。

桂枝去芍药汤及加附子汤

误下后脉促、胸满，表邪仍在而胸阳受损，去芍药之酸敛以畅胸阳；兼微恶寒则再加附子温阳。

干姜附子汤

下后复汗，昼烦躁不得眠而夜安静，不呕不渴、无表证、脉沉微、身无大热，是阴盛阳虚的昼间虚躁，不是阳明热烦，宜急温阳。

桂枝新加汤

汗后身痛、脉沉迟，为营血气津受伤而肌肉失养。桂枝汤增芍药、生姜并加入参，调营卫兼益气和营；与麻黄汤的脉浮紧、无汗实痛相反。

麻黄杏仁甘草石膏汤

汗后仍汗出而喘、无大热，是邪热壅肺，清宣肺热，不可再用桂枝汤。太阳下后同类热喘亦适用。它与桂枝加厚朴杏子汤的表虚微喘、小青龙汤的寒饮喘应严格区分。

桂枝甘草汤

汗多后心阳虚，叉手自冒心、心下悸而喜按；桂枝、炙甘草温通心阳。

茯苓桂枝甘草大枣汤

汗后脐下悸、欲作奔豚，是下焦水气欲上冲；重用茯苓并以桂枝温阳降冲。

厚朴生姜半夏甘草人参汤

汗后腹胀满，以脾胃气虚、气滞痰阻为主。厚朴、生姜、半夏行气除满，人参、甘草扶中；不属于承气汤的燥实腹满。

茯苓桂枝白术甘草汤

吐下后心下逆满、气冲胸、起则头眩、脉沉紧，是中阳受伤、水饮上逆。若再汗会动经而振摇，故温阳健脾利水。

芍药甘草附子汤、茯苓四逆汤

汗后反恶寒，是阳虚，前者兼阴液筋脉失养；汗下后病不解而烦躁，兼气阳大虚、水气不化，用茯苓四逆汤温阳益气利水。

五苓散

汗后脉浮、微热、烦渴而小便不利，或水入即吐的“水逆”，病机是膀胱气化不利、水停而津不上承。辨别点是渴与小便不利并见，治在化气行水而非单纯补水。汗出而渴属此；不渴而心下悸者偏胃阳不化，用茯苓甘草汤。饮水过多或冷水外灌均可使水气射肺而喘。

真武汤

太阳误治后仍发热、心悸、头眩、身瞤动、振振欲擗地，是阳虚水泛；同少阴篇腹痛、小便不利、四肢沉重、自利的真武汤证互参。五苓散偏气化不利而正虚较轻，真武汤则肾阳虚、水气泛动更重。

桂枝去桂加茯苓白术汤所治，是服桂枝或误下后头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利；小便利则愈。其病机究属水停中焦而表证样表现，方名“去桂”历来有争议，临床应以小便不利、心下满痛为核心，不能仅按头项强痛再发汗。

3.2.5 虚烦、火逆与神志变证

汗吐下后虚烦不得眠、反复颠倒、心中懊憹而无有形实结，用栀子豉汤清宣郁热。少气加甘草，呕加生姜；兼腹满、卧起不安用栀子厚朴汤；丸药大下后身热微烦而中寒，用栀子干姜汤寒温并调。若胸中窒、心中结痛，仍可据无形郁热用栀子豉汤。与阳明燥屎的腹满硬痛、潮热谵语相比，栀子豉汤证以懊憹、胸膈郁热而腹无燥实为要。

火劫发汗可使风邪与火热相合，耗血伤阴，出现发黄、欲衄、头汗齐颈而还、腹满微喘、口干咽烂、谵语、哕、捻衣摸床；小便利表示津液气化尚存，预后相对较好。火迫亡阳而惊狂、卧起不安，用桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤温通心阳、重镇潜阳；烧针处受寒起赤核、奔豚从少腹冲心，灸核并用桂枝加桂汤；火逆又下、烧针后烦躁，用桂枝甘草龙骨牡蛎汤。三方均治惊悸烦躁，但一重火劫惊狂，一重奔豚上冲，一重心阳受伤后的烦躁。

吐法过度可损胃阳：本应发热恶寒而反自汗、不恶寒发热，关脉细数，继见饥而不能食、喜冷、朝食暮吐，属胃虚冷而客热在上。脉数不必皆是实热；若能食反吐，亦可能阳气微、膈胃虚寒。

3.2.6 少阳兼证、蓄血、结胸与痞证

太阳病进入少阳，见往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕，以小柴胡汤和解。七个主药分别疏少阳、清胆热、和胃降逆、益气扶正。兼证加减围绕胸烦、渴、腹痛、胁下痞硬、心悸小便不利、外有微热、咳嗽展开。“但见一证便是，不必悉具”是说抓住少阳枢机不利的关键证，不是见任何孤立症状都用柴胡。口渴而饮水即呕、食谷则哕者，胃中水逆而非柴胡证，禁用。

腹中急痛而脉阳涩阴弦，先用小建中汤温中缓急；不差再考虑小柴胡汤。呕家因胶饴甘甜碍胃，不宜小建中。小柴胡证误下而证仍在，仍可和解，常见战栗、发热、汗出而解。若呕不止、心下急、郁郁微烦，已由少阳兼阳明里实，改大柴胡汤和解兼下；潮热实证经丸药误下而微利，先小柴胡解外，再柴胡加芒硝汤清里。下后胸满烦惊、小便不利、谵语、一身尽重，用柴胡加龙骨牡蛎汤和解少阳、通阳利水、镇惊泄热。

太阳蓄血的共同点是少腹急结或硬满、小便自利、精神如狂；小便自利把血证同水蓄膀胱区别开来。轻者热结膀胱、血可自下而愈，外未解先解外，外解后用桃核承气汤逐瘀泄热。发狂、少腹硬满、脉微沉或身黄而小便自利者，用抵当汤；病势较缓，仅少腹满、小便反利，用抵当丸。若少腹硬而小便不利，则首先考虑水停，不可误作蓄血。

结胸与痞都可由误下邪陷形成，但性质不同：结胸是有形水热或寒实结聚，按之痛；痞是气机壅塞，按之濡或满而不痛。

大陷胸丸、大陷胸汤

大结胸见心下至少腹硬满疼痛、拒按、脉沉紧，或项强如柔痉。病位较高、势较缓用丸；水热互结、痛势急重用汤。舌燥渴、日晡潮热而胸腹硬痛，也属大陷胸汤证。得快利即止，体虚者慎用。

小陷胸汤

病正在心下，按之始痛，脉浮滑，为痰热互结，黄连清热、半夏化痰、栝楼实宽胸，病

势较大陷胸轻。

白散

无热、寒实结胸，用桔梗、贝母、巴豆温下寒实；峻烈有毒，须严格按体质减量，并以冷热粥调节吐利，不能与小陷胸汤混用。

十枣汤

表已解而水饮结于胸胁，心下痞硬满、引胁痛、干呕短气、汗出不恶寒，属悬饮，不是一般痞证。芫花、甘遂、大戟峻逐水饮，平旦空腹小量服，得快利后以粥养胃。

半夏泻心汤

呕而发热、柴胡证经误下后，只满不痛，是中焦寒热错杂、升降失常。半夏、干姜辛开，黄芩、黄连苦降，人参、甘草、大枣扶中。

大黄黄连泻心汤与附子泻心汤

心下痞、按之濡、关脉浮，属无形热痞，用沸水渍大黄、黄连以清泄上部之热；若又恶寒汗出，为热痞兼表阳虚，加附子另煎温阳，体现寒热分治。

生姜泻心汤

汗解后胃不和，心下痞硬，干噫食臭、胁下水气、腹中雷鸣、下利，是水食互结，以生姜和胃散水为特色。

甘草泻心汤

误下再下，谷不化、日数十利、雷鸣、痞硬、干呕心烦，是中气大伤、客气上逆，重用甘草扶中。节录本缺人参，宋臣校语据他本认为脱漏。

赤石脂禹余粮汤

泻心汤、再下、理中后下利仍不止，病已在下焦滑脱，用涩剂固下；仍不止则从“利小便以实大便”处理。它不同于太阴中焦虚寒的理中法。

旋覆代赭汤

汗吐下解后，心下痞硬、噫气不除，是胃虚痰阻、胃气上逆，以旋覆花、半夏、生姜化痰降逆，代赭石重镇，人参甘枣扶胃。

桂枝人参汤

表未解而屡下，协热下利不止、心下痞硬，属表里同病，以理中法温中止利，桂枝后下解表；与纯热痞的泻心汤法不同。

痞证兼外不解，仍应先桂枝汤解表，后以大黄黄连泻心汤攻痞。心下痞兼渴、口燥烦、小便不利而泻心不解，应转辨水气，用五苓散。发热汗出、痞硬、呕吐下利而里实较重，可用大柴胡汤。若头项不痛、胸中痞硬、气冲咽喉不得息，属胸中寒实，可用瓜蒂散吐之；亡血、虚家禁吐。

妇人经水适来或适断，外邪乘虚入血室，可见胸胁满、寒热如疟、暮则谵语。偏实可刺期门，少阳证明显用小柴胡汤；若白昼清楚、暮则谵语而无犯胃与上焦，多可自愈，不应见谵语便攻下。太阳少阳并见发热微恶寒、肢节烦疼、微呕、心下支结，用柴胡桂枝汤；误汗下后胸胁微结、往来寒热、头汗、渴而不呕、小便不利，用柴胡桂枝干姜汤和解少阳兼温化水饮、生津散结。

此外，太阳与少阳合病而下利，用黄芩汤清少阳热、和营止利；兼呕加半夏、生姜。胸中有热、胃中有寒邪，腹痛欲呕，用黄连汤寒热并调。脉结代、心动悸，为气血阴阳俱不足，

炙甘草汤益气养血、通阳复脉。白虎加人参汤仅用于表解后气津两伤而里热炽盛；表未解、无汗脉浮者禁用，亡血虚家也须慎。季节禁忌属于古代方后注文，仍应以证候和体质为准。

3.3 阳明病：胃家实、津伤与热证转归

3.3.1 提纲与形成

“阳明之为病，胃家实是也。”（PDF 第 56 页，原书第 52 页）

“胃家”包括胃肠，“实”既指邪热炽盛，也指燥屎、宿食等有形实结。阳明外证为身热、汗自出、不恶寒反恶热，脉多洪大。太阳病经发汗、攻下、利小便后津液亡失，胃中干燥，大便难而转属阳明；太阳无汗、呕不能食而后濇然汗出，也提示转阳明。阳明病并非全都可下：初转阳明、外证未尽、湿热发黄、胃寒呕逆、津亏便硬，治法均不同。

脉浮缓、手足温可暂系太阴；若小便自利、不发黄，七八日后大便硬，才转为阳明。阳明中风仍可见口苦咽干、恶寒、脉浮紧，说明表邪未清，误下会腹满、小便难。脉迟、食难饱、饱则烦眩、小便难，偏中阳不足而湿郁欲发谷疸，攻下不能解除腹满。久虚者即使阳明，也可能无汗而如虫行皮中。

3.3.2 三承气汤的层级与试探法

调胃承气汤

邪热在胃、燥结初成而腑气壅滞不重，见不吐不下而心烦，或太阳汗吐下后微烦、小便数、大便硬，或吐后腹胀满。大黄、芒硝泄热软坚，甘草缓中，重在“调胃气”。

小承气汤

燥实较轻而腑气不通，见潮热、谵语、腹满，大便硬但痞满燥实未全。无芒硝、厚朴枳实用量较轻，可作诊断性试服：服后转矢气，说明燥屎阻结，可继续攻；不转矢气，多为初硬后溏或里虚，严禁再攻。

大承气汤

痞、满、燥、实俱重：日晡潮热、不恶寒、手足濇然汗出、腹满硬痛拒按、绕脐痛、燥屎、谵语，或不大便日久。厚朴、枳实行气除痞满，大黄泻热，芒硝软坚。先煎厚朴、枳实，后下大黄、芒硝，体现先行气后攻坚；得下即止。

大便微硬而潮热，可考虑大承气；不硬不可用。能食而谵语潮热，多为便硬；不能食则燥屎更重。多汗伤津导致大便硬、谵语而腹实不重，可先小承气，中病即止。脉滑疾可攻，转为微涩则里虚难治，不可再承气。目不了了、睛不和而大便难，阳明发热汗多而津将竭，以及发汗不解而腹满痛，是原文三条“急下”证；腹满不减、减不足言则另称“当下”。这些证候均不可因等待典型潮热而延误。

谵语属实热，郑声是虚弱重语。直视谵语兼喘满或下利，提示正衰邪盛；吐下后十余日潮热、独语如见鬼、循衣摸床、微喘直视，脉弦尚有胃气则生，脉涩津血枯竭则危。重汗亡阳也可谵语，因此仍须结合脉证，脉和者可生、脉短者危，不能把谵语一律视为承气证。

呕多、心下硬满、面色赤、外证未解均不宜攻。阳明自汗又误汗、且小便自利，津液内竭，即使大便硬也不可攻，可待便意后用蜜煎导、猪胆汁等局部润导。这里与麻子仁丸的脾约不同：前者是治疗后津枯、正气不任攻下，后者是胃强脾弱、津偏渗膀胱而小便数、大便硬，以麻子仁丸润肠泄热、行气缓下。

3.3.3 阳明热证、水热、血证与发黄

三阳合病见腹满身重、口不仁、面垢、谵语遗尿而自汗，以白虎汤清气分大热；误汗会加重谵语，误下可额汗肢冷。阳明汗出、恶热、口干舌燥、大渴者用白虎加人参汤清热益气生津。若脉浮发热、渴而小便不利，是水热互结，用猪苓汤育阴清热利水；汗多、胃燥而渴者禁用猪苓汤，以免再利小便伤津。

阳明误下后外有热、心中懊憹、饥不能食而仅头汗，或舌上有苔、胸膈烦闷，属无形郁热，用栀子豉汤。阳明兼少阳而潮热、大便溏、胸胁满，或胁下硬满、不大便而呕、舌苔白，用小柴胡汤开上焦、布津液、和胃气；和解后濈然汗出可愈，不能一见不大便即攻阳明。

发黄要分湿热、寒湿及表郁：

- 茵陈蒿汤证：但头汗出、身无汗、汗齐颈而还，小便不利、渴引水、腹微满，身黄鲜明如橘子色，为湿热瘀结。茵陈清利湿热，栀子清三焦，大黄泄瘀热，黄从小便而去。
- 栀子柏皮汤证：身黄兼发热，里热较著而腑实不明显，清热利湿。
- 麻黄连轺赤小豆汤证：瘀热在里而兼表郁，麻黄、生姜疏表，连轺、赤小豆、梓白皮清利湿热。
- 寒湿发黄：汗后身目黄，寒湿在里，非热实可下，应从温化寒湿求治。阳明脉迟、食少、小便难而欲作谷疸也偏湿困，不宜妄下。

阳明口燥但漱水不欲咽，提示血热，可能鼻衄。喜忘、便硬却反易解、色黑，是久瘀蓄血，用抵当汤；它与燥屎的便难、潮热腹痛不同。食谷欲呕而属阳明，是胃中虚寒，吴茱萸汤温胃降逆；服后反剧提示病位在上焦，须重新辨证。

3.4 少阳病：枢机不利，以和解为主

“少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。”（PDF 第 61 页，原书第 57 页）

少阳处于表里之间，枢机不利时，胆火上扰则口苦、咽干、目眩，正邪相争则往来寒热，胆胃不和则胸胁满、默默不欲食、心烦喜呕，脉多弦细。太阳不解转入少阳，见胁下硬满、干呕不能食、往来寒热、脉沉紧，主小柴胡汤。

少阳禁汗、禁吐、禁下。汗可伤津并使邪热入胃而谵语；吐下可伤正，导致心悸惊恐。少阳中风兼耳聋、目赤、胸满烦，尤其不能吐下。若误治后胃和，仍可自愈；胃不和则烦悸，应转治胃。太阳篇中小柴胡、大柴胡、柴胡加芒硝、柴胡加龙骨牡蛎、柴胡桂枝、柴胡桂枝干姜诸方，分别展示少阳兼表、兼里实、兼水饮与误下惊悸的处理。其共同底线是有少阳枢机证才用柴胡，不以单一“发热”或“胁满”概括。

3.5 太阴病：中阳不足，寒湿内盛

太阴提纲是腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛；若误下，中阳更伤，胸下结硬。其核心为脾阳不足、运化失司，故腹满、吐利并见，而且自利不渴；不渴区别于热利和少阴虚寒引水自救的口渴。治宜温中，以理中、四逆辈为主。

太阴中风见四肢烦疼，脉阳微、阴涩而长，是正气来复、将愈之候。太阴病兼太阳表证而脉浮，仍可用桂枝汤解表，但应取微汗，不能用麻黄峻汗。脉浮缓、手足温而系太阴者，本可因寒湿发黄；若小便自利，湿有去路则不黄。七八日突然烦而下利频作，若脾阳

尚能恢复、腐秽外出，可自行停止，不应见利即涩止。

太阳误下后腹满时痛，属太阴脾络不和，用桂枝加芍药汤调和营卫、缓急止痛；若腹痛大实，兼有实滞，用桂枝加大黄汤。太阴脉弱而持续自利，胃气易动，即使应当用大黄、芍药，也须减量。这里的“大实痛”不是纯阳明燥实：仍以太阴误下、中焦失和为背景，故保留桂枝汤结构，只少佐大黄。

3.6 少阴病：阳虚寒化与阴虚热化

“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”（PDF 第 62 页，原书第 58 页）

少阴病位在心肾，提纲以脉微细、精神衰惫为正虚标志。欲吐不吐、心烦但欲寐，五六日自利而渴，小便清白，是下焦阳虚不能制水，口渴为虚寒病人引水自救，不等于里热。阴阳脉俱紧却反汗出，是亡阳之象，可继发咽痛、吐利。脉细沉数、脉微及尺弱涩者，均禁汗下；七八日下利而手足转温、紧脉退去，是阳回欲解。

3.6.1 少阴表证与寒化证

麻黄附子细辛汤

少阴初病反发热而脉沉，是阳虚外感。麻黄解表，附子温少阴，细辛通彻表里。与太阳麻黄汤相比，关键是脉沉、阳虚；不可发大汗。

麻黄附子甘草汤

少阴二三日、尚无明显的里证，用甘草缓麻黄之发散，微汗解表，病势较前方轻缓。

附子汤

口中和而背恶寒，或身体、骨节疼痛、手足寒、脉沉，是肾阳虚寒、寒湿留着。附子温肾，参苓扶脾利湿，芍药和营止痛。背恶寒而口不渴，与白虎加人参汤热盛津伤而背微恶寒相反。

桃花汤

少阴虚寒下利、便脓血，兼腹痛、小便不利、利不止，以赤石脂涩肠固脱，干姜温中，粳米养胃。中病即止，不能用于湿热血痢。

吴茱萸汤

吐利、手足逆冷、烦躁欲死，为肝胃虚寒、浊阴上逆，以吴茱萸、生姜温胃降逆，人参、大枣扶正。厥阴干呕、吐涎沫、头痛亦用本方，体现同方异经但病机相通。

白通汤及白通加猪胆汁汤

少阴下利、阳气衰微，用葱白通阳，干姜、附子回阳。下利不止、厥逆无脉、干呕烦，阴寒格拒阳药，加猪胆汁、人尿反佐，使热药顺入；服后脉骤然暴出是残阳外脱，脉逐渐续出才是阳回可生。

真武汤

腹痛、小便不利、四肢沉重疼痛、自下利，或咳、呕，是肾阳虚、水气泛滥。与太阳误汗后振摇的真武汤证同机；加减根据水气偏肺、偏胃、偏肠而定。

通脉四逆汤

下利清谷、手足厥逆、脉微欲绝而身反不恶寒、面赤，是里寒外热、阴盛格阳。较四逆汤证更重，重用干姜并用生附子，脉徐徐来者愈。

四逆汤

少阴脉沉、阴寒内盛时须“急温”；若膈上寒饮、干呕而非胸中实，也不可吐，宜四逆汤。四逆汤所治的厥是阳虚寒厥，与白虎汤热厥、四逆散气郁厥不同。

3.6.2 少阴热化、咽痛与急下证

少阴二三日以上心中烦、不得卧，是肾阴不足、心火独亢，用黄连阿胶汤：黄连、黄芩清心火，阿胶、芍药、鸡子黄滋阴养血。它与干姜附子汤“昼烦夜静”的阳虚躁扰相反，也与栀子豉汤病后无形郁热不同。

少阴咽痛须分层：下利、咽痛、胸满心烦，属阴虚兼热，用猪肤汤滋养润燥；初起咽痛先甘草汤，不差用桔梗汤清利咽喉、宣肺排脓；咽中伤、生疮、失音用苦酒汤涤痰敛疮；咽痛兼寒邪痰阻，用半夏散及汤辛温散结。节录本方后自注“半夏有毒，不当散服”，实际应用宜煎汤并严格炮制。

少阴下利六七日而咳、呕、渴、心烦不得眠，是水热互结兼阴伤，用猪苓汤。另有三条“少阴急下”：口燥咽干；自利清水色纯青、心下痛、口干燥；六七日腹胀不大便。三者虽冠少阴，实为少阴阴液将竭而阳明燥实已成，急用大承气汤是“急下存阴”，绝不可与少阴虚寒清谷利混淆。

四逆散治阳气郁遏、不能达于四肢的气厥，虽手足逆冷，但正气未衰，常兼胁腹不舒、咳悸、小便不利、腹痛或下重，脉不以微欲绝为主。柴胡、枳实升降气机，芍药、甘草和营缓急；这是辨“厥”不可只凭手足温度的重要范例。

3.7 厥阴病：阴阳不相顺接与寒热错杂

厥阴提纲为消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食、食则吐蛔，误下则利不止。上部有热、下部有寒，寒热错杂且升降逆乱，是其典型结构。凡四肢厥逆及虚家，原则上不可妄下。厥的定义是阴阳气不相顺接而手足逆冷，不等同于“寒证”；须辨寒厥、热厥、血虚寒厥、气郁厥、水饮厥和蛔厥。

伤寒一二日至四五日，发热与厥可相互出现；“厥深者热亦深，厥微者热亦微”说明热邪郁闭越重，外见肢冷越深。热厥本可清下，若误汗会伤津，口舌糜烂。脉滑而厥是里热，主白虎汤；大汗后热不去、内拘急、肢痛、下利厥逆恶寒，或大汗大下利后厥冷，才是阳虚寒厥，用四逆汤。

3.7.1 厥阴主要方证

乌梅丸

蛔厥及久利。蛔厥特点是平时较静、阵发烦躁，得食而呕、烦复发，且有吐蛔史；因脏寒使蛔上扰，又夹上热。乌梅、苦酒酸收安蛔，蜀椒、细辛、干姜、附子、桂枝温脏，黄连、黄柏清上热，人参、当归扶正养血。脉微、肤冷、持续躁无暂安是脏厥，属脏阳衰败，不可误当蛔厥。

当归四逆汤

手足厥寒、脉细欲绝，为血虚寒凝、经脉不畅。以当归、芍药养血，桂枝、细辛温经，通草通脉，甘草大枣扶中。内有久寒者加吴茱萸、生姜并以水酒同煎。与四逆汤相比，本证以血虚寒凝、脉细为主，并无下利清谷、脉微欲绝的亡阳表现。

茯苓甘草汤

厥而心下悸，先治水饮，再治其厥；若不先化水，水渍入胃可作下利。体现“先处理致厥因素”而非见厥即温阳。

麻黄升麻汤

大下后寸脉沉迟、手足厥、下部脉不至、咽喉不利、唾脓血、泄利不止，属误下后上热下寒、正虚邪陷的复杂证。方中升麻、麻黄升散，黄芩、知母、石膏清上热，干姜、白术温中，当归、芍药养血，诸药寒温并用。原方药味文字有异文，见校勘说明。

干姜黄连黄芩人参汤

本来寒利，又经误吐误下，形成寒格、食入口即吐。干姜温中，黄连黄芩清上热，人参补虚，治寒热格拒、胃气上逆。

白头翁汤

热利下重、欲饮水，为厥阴湿热痢，白头翁、秦皮、黄连、黄柏清热燥湿、凉血止痢。与太阴自利不渴、少阴清谷利、桃花汤虚寒脓血利相反。

通脉四逆汤

下利清谷、里寒外热、汗出而厥，为阴盛格阳；与少阴同一病机，说明方证可以跨经互见。

小承气汤

下利而谵语，是肠中燥屎内结、热迫旁流，不可因“下利”误作虚寒，宜小承气通燥实。

热少微厥、指头寒，若数日后小便清白、烦热退、欲食，是热退胃和、病欲愈；若厥而呕、胸胁烦满，可能热伤血络而后便血。下利腹胀满兼身体痛，与太阳篇相同，先四逆汤温里，再桂枝汤攻表。呕而脉弱、小便自利、微热见厥，正虚邪恋，属难治，可据阳虚用四逆汤。干呕、吐涎沫、头痛为肝胃虚寒，用吴茱萸汤；呕而发热、有少阳枢机证，则用小柴胡汤。

3.8 霍乱：吐利并作，先辨寒热与亡阳

霍乱以突然呕吐、下利并作为定义，可兼发热、头痛、身痛、恶寒；吐利停止后又发热，提示里邪稍退而表证显出。诊治先看口渴、寒热、脉与四肢：

- 头痛发热、身痛、热多欲饮水，用五苓散化气行水，使水津布达；寒多、不欲饮水，用理中丸或理中汤温中健脾。理中方可随脐上筑、吐多、下多、悸、渴、腹痛、寒、腹满加減，但腹满去术加附子须结合中阳虚寒，不能用于热实满。
- 恶寒、脉微而利，利止并不必是病愈，可能是吐利后津血大伤，用四逆加人参汤回阳益气生津。
- 吐利停止而身痛不休，里气已和，可用桂枝汤小和其外，仍须微汗。
- 吐利汗出、发热恶寒、四肢拘急、手足厥冷，或下利清谷、小便自利、大汗、内寒外热、脉微欲绝，均属亡阳，急用四逆汤。
- 吐利已止而汗出、厥逆、拘急不解、脉微欲绝，用通脉四逆加猪胆汁汤。猪胆汁为反佐，以防阴盛格拒；脉逐渐恢复为佳。

吐利、发汗之后脉已平而仅小烦，是新虚、胃气暂不能胜谷气，不宜再攻；应节制饮

食、静待恢复。霍乱篇把五苓散、理中、四逆、桂枝并列，清楚展示“同为吐利，水热、中寒、亡阳、表未解”治法完全不同。

3.9 阴阳易与差后劳复：病后调摄重在辨余邪与正虚

本节选文虽题为“辨阴阳易差后劳复病脉证并治”，实际收录从第 393 条起，仅见差后劳复诸证，未选录阴阳易的烧裨散条，故不据节题补写未见原文。

枳实栀子豉汤

大病初愈因劳而复发，见胸中郁热、心烦，用枳实行气、栀子清热、豆豉宣郁，并覆取微汗。兼宿食可加大黄少量泄滞。

小柴胡汤或汗下分治

病后再发热，若少阳证在，用小柴胡；脉浮、余邪在表，可汗解；脉沉实、里实已成，可下解。必须以脉证决定，不能把所有复热视为劳复。

牡蛎泽泻散

大病后腰以下水肿，是水气停聚下焦，用牡蛎、泽泻、蜀漆、葶苈子、商陆根、海藻、栝楼根逐水；小便利即停，防止过利伤正。

理中丸

病后喜唾、久不愈，胸上有寒，属中阳不足、寒饮上泛，宜温中化饮。

竹叶石膏汤

伤寒解后虚羸少气、气逆欲吐，是余热未清而气津两伤。竹叶、石膏清余热，麦冬养阴，人参、甘草、粳米益气和胃，半夏降逆。与白虎汤纯清气热相比，本方清补并行；与理中丸病后寒饮相反。

病后脉已解而日暮微烦，若源于强令进食、脾胃尚弱不能消谷，只须减食即可，不应再投苦寒攻下。差后调摄的总原则是少劳、节食、察余邪、护胃气；既不能见虚便一味峻补，也不能见复热便再汗再下。

3.10 核心方证鉴别速查

有汗恶风

营卫不和，发热头痛、脉浮缓：解肌调营卫，桂枝汤。若微喘，加厚朴杏子；项背强，加葛根；漏汗肢急，加附子。

无汗身痛

寒束太阳、脉浮紧而喘：发汗解表，麻黄汤。兼烦躁里热用大青龙；兼心下水饮、咳嗽干呕用小青龙。

汗出而喘

若表虚误下、微喘，用桂枝加厚朴杏子汤；若汗后邪热壅肺、无大热，用麻杏甘石汤；若下利清谷、厥逆脉微，则不是肺热喘，应先四逆救里。

渴与小便不利

脉浮微热、水入即吐，用五苓散；兼心烦不得眠、下利咳呕而属水热互结，用猪苓汤；阳虚水泛兼眩晕振摇、四肢沉重，用真武汤。

心下痞

按之濡、热痞用大黄黄连泻心汤；恶寒汗出兼阳虚加附子；干噫食臭、雷鸣下利用生姜泻心；反复误下、谷不化、日数十利用甘草泻心；噫气不除用旋覆代赭汤。

心下痛硬

按之痛、脉沉紧、水热结胸用大陷胸汤；仅心下按痛、脉浮滑用小陷胸；满而不痛偏痞；胸胁满、往来寒热偏少阳，用小柴胡。

腹满便秘

潮热、手足濇汗、硬满拒按、燥屎用大承气；痞满较轻用小承气并以转矢气验证；仅心烦、燥结初起用调胃承气；津枯不任攻下用蜜煎导；小便数、脾约便硬用麻子仁丸。

四肢厥逆

下利清谷、脉微欲绝为阳虚寒厥，用四逆或通脉四逆；脉滑为热厥，用白虎；脉细欲绝、血虚寒凝用当归四逆；胸胁不舒、脉不微绝为气郁厥，用四逆散；心下悸先治水饮；阵发烦躁、食入吐蛔为蛔厥，用乌梅丸。

下利

太阴自利不渴，用四逆辈温中；少阴清谷、脉微厥冷，用四逆或白通；便脓血而虚寒，用桃花汤；热利下重、口渴，用白头翁汤；谵语兼下利反属燥屎旁流，用小承气；表里俱病且里寒危急，先温里后解表。

病后发热或烦

劳复胸中郁热用枳实栀子豉汤；少阳余邪用小柴胡；气津两伤、虚羸少气、气逆欲吐用竹叶石膏汤；强食后日暮微烦只须减食。

3.11 校勘说明

1. PDF 第 40、43 页（原书第 36、39 页）“项背强”后有两个缺字，按通行本校作“项背强几几”；意为项背拘急不舒。方剂煎法中“咀”前的缺字属于古代制药用语“咬咀”，本笔记不依赖该字说明方证。
2. PDF 第 40 页（原书第 36 页）桂枝加葛根汤方列麻黄三两，但同页宋臣校语指出太阳中风汗出恶风本不应有麻黄，疑原方为桂枝汤加葛根。本文正文保留这一异文，不擅自据一说改定古方。
3. PDF 第 42 页（原书第 38 页）第 27 条“脉微弱者，此无阳也，不可发汗。宜桂枝二越婢一汤”表面矛盾。本文按“小剂调和、不可峻汗”解释；“无阳”也可理解为无阳热实证，并非典型亡阳，仍属历代争议。
4. PDF 第 50、52、59 页（原书第 46、48、55 页）“剂颈而还”统一校为“齐颈而还”；PDF 第 52 页“柔痊”按现代规范写作“柔痊”。方后多见的“内”通“纳”，正文均按现代语义表述。
5. PDF 第 49 页（原书第 45 页）大柴胡汤方正文未列大黄，方后注明“一方加大黄二两，若不加，恐不为大柴胡汤”。本文按其和解少阳兼攻里实的主流方义说明，同时保留原文版本差异。
6. PDF 第 54 页（原书第 50 页）甘草泻心汤方未列人参，宋臣据《千金》《外台秘要》认为脱漏。本文不改原方文字，只在方义中提示此校勘意见。
7. PDF 第 56 页（原书第 52 页）白虎汤第 176 条作“脉浮滑，此表有热，里有寒”，紧

接的宋臣校语认为“表里字差”，且与前后禁用白虎汤条矛盾。本文仅按白虎汤清里热的体系理解，不采用“里寒”字面作为用方依据。

8. PDF 第 46 页芍药甘草附子汤、PDF 第 56 页黄连汤均附“疑非仲景方”；这是底本校者意见，不足以直接判定真伪，故正文按节录本方证收录并提示辨证边界。
9. PDF 第 66 页（原书第 62 页）麻黄升麻汤药味夹注“萎蕤，一作菖蒲”等异文，排版又使“去心”“去皮”等炮制语串行。正文只概括寒热并用、升降扶正的结构，不据该页重排药量。
10. 本笔记所称页码均按文件内 PDF 页码；括号内原书页码取各页版心页码。阅读范围自 PDF 第 39 页“伤寒论篇”起，至 PDF 第 68 页第 398 条止。

4、《金匱要略》精读笔记

4.1 阅读范围与总纲

本笔记据 PDF 第 69–104 页整理，覆盖《金匱要略》第一至第二十二篇在本 PDF 中实际出现的条文与方剂。PDF 页码与书内页码相差四页，例如 PDF 第 69 页为原书第 65 页。第 104 页只读到“胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，膏发煎导之”为止；其后的“温病学篇”“温热论”不属于本节，故不纳入。本文重在经典条文的病机、证候、治法和方证鉴别，不把古方名称直接等同于现代疾病诊断。

《金匱要略》的组织方式可用五层框架把握：

1. 杂病辨治。先辨病位（表、里、脏、腑、经络），再辨病性（寒、热、虚、实、痰、水、瘀、毒），并落实“先后”“缓急”“标本”次序。痼疾兼卒病时先治卒病；误下之后须判断救里还是救表；同一症状因病机不同而异治。
2. 脏腑经络。第一篇以“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”为纲，说明未病先防、截断传变；第五至第十一篇把风中经络、胸痹、寒疝、积聚、肺痿肺痛等落实到脏腑气血的升降出入。
3. 痰饮水气。第十二至第十四篇把“饮”按停留部位分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮，并以脉、渴否、肿胀上下、喘咳和小便利否决定温化、汗解、逐水或利尿，体现水液代谢与肺脾肾三脏协同。
4. 气血津液。痉、喝、百合、疟、虚劳、肺痿、吐衄下血、黄疸及疮痈，分别从津液耗伤、营卫失和、血瘀、湿热、毒邪和正虚解释症状。方剂常以和营卫、温阳、清热、活血、润燥互相配伍，不能只看单味药的功效。
5. 妇科。妊娠、产后及妇人杂病都以冲任、胞宫、血室为核心，同时兼顾脾胃、肾气和气血。妊娠期以安胎、养血、利水为主，产后先辨血虚、亡津、瘀血与中风，再决定温补、活血、通腑或解表。

安全提示。原书的乌头、附子、巴豆、甘遂、大戟、芫花、蜀漆、雄黄、硝石、矾石、虻虫、水蛭、土鳖虫等，或为峻下逐水、破血、走窜、温阳峻剂，或有明显毒性。下文的“主方”是经典方证学习与辨证思路的记录，不是自行煎服、替代诊疗或孕产期用药建议；涉及急性呼吸困难、咯血、神志改变、持续高热、妊娠出血和产后异常出血时，应及时就医。

“夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”

4.2 脏腑经络先后病脉证第一：总纲与诊法

病机与治则。肝病可乘脾，故肝虚以酸补、焦苦相助、甘味调和；肝实则不可误补。所谓“虚虚实实，补不足，损有余”，是反对虚证再攻、实证再补。五脏皆按此法推演。条文又把病因归为三类：经络受邪而内传脏腑，皮肤四肢九窍受邪而外闭，房室、金刃、虫兽所伤。未入脏腑时可用导引、吐纳、针灸、膏摩等早治；饮食寒热辛甘须有节，房劳不可竭乏，腠理才不易受邪。

望色、闻声与呼吸。鼻头青兼腹中冷痛提示脾肾阳败，属危候；微黑主水气，黄主胸上寒，白主亡血，非时微赤为危。面色青主痛、黑主劳、赤主风、黄主便难、鲜明主留饮。声音寂静而突然惊呼偏骨节，暗而不彻偏心膈，细长偏头中；息摇肩为心中坚，息引胸中上气为咳，张口短气兼唾沫提示肺痿。面色与四时脉色相反，属于“非其时色脉”，应结合全身辨病，不能单凭一项定论。

表里、脏腑与急缓。浮脉在前主表，在后主里；里证可见腰痛背强、短气。沉大滑脉为实气相搏，入脏则唇青身冷而死，入腑则身和汗出而愈；“浸淫疮”由口向四肢流可治，由四肢向口流则危，借外向内说明邪势。误下后清谷不止、身体疼痛，先救里；清便自调而后身痛，则先救表。痼疾兼卒病，先治卒病。脏病应随其“所得”而攻，例如渴而水停可用猪苓汤，余证类推。

临床联系。这一篇相当于一套风险分层算法：先确认生命危险与病位，再决定是否攻下、发汗或温补；“入脏即死、入腑即愈”是古代病势判断，不可机械套用到现代患者。面色、脉象和症状必须合参，并以现代检查排除急腹症、感染、出血及心肺危重病。

4.3 痉湿喝病脉证治第二：筋脉拘急与湿热水湿

辨证主线。刚痉为太阳病发热无汗而恶寒，柔痉为发热汗出而不恶寒；身热足寒、颈项强急、头摇口噤、背反张是痉病全貌，痉脉按之紧如弦、直上下行。湿痹见关节疼痛、脉沉细（或缓）、小便不利而大便反快，治当利小便；湿家一身疼、发热、色如熏黄，常夹风或困于头部。风湿发汗宜“微似欲出汗”，大汗只去风而湿留。喝是暑热伤津，汗出恶寒、身热而渴，属气津两伤。

栝楼桂枝汤

证机：太阳表证兼津液不足、筋脉失养。主症：表证备而身体强、几几然，脉反沉迟。治法：解肌发表、养津柔筋，取微汗。方剂：栝楼根、桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。辨别点：与葛根汤的无汗、气上冲、口噤相别；本方脉沉迟、项背强而偏虚。

葛根汤

证机：风寒束表、太阳经输不利，津液不布。主症：无汗、小便少、气上冲胸、口噤不得语，欲作刚痉。治法：发汗解肌、升津舒经。方剂：葛根、麻黄、桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。辨别点：无汗、脉紧及表寒较明显；已有大汗、里热或津亏者不宜误用辛温发汗。

大承气汤

证机：刚痉阳明腑实，燥屎内结、腑气不通。主症：胸满、口噤、卧不着席、脚挛急、齟齿。治法：峻下热结。方剂：大黄、厚朴、枳实、芒硝。辨别点：必有明显里实、腹满便秘或谵语等趋势，与表寒筋急相别；芒硝、大黄为峻下药，仅作经典辨证学习。

麻黄加术汤

证机：寒湿束表，湿邪黏滞肌肉关节。主症：身烦疼、发热，湿家身重。治法：微汗解表、健脾燥湿。方剂：麻黄、桂枝、杏仁、甘草、白术。辨别点：慎火攻；若风湿俱重而体虚自汗，转用防己黄芪汤。

麻黄杏仁薏苡甘草汤

证机：风湿郁表、湿热偏重。主症：一身疼、发热，午后加重，病起于汗出当风或久取冷。治法：轻宣肺气、祛湿解表。方剂：麻黄、杏仁、薏苡仁、甘草。辨别点：力较麻黄加术汤缓，要求微汗并避风。

防己黄芪汤

证机：表虚卫外不固，风湿在表兼脾虚运化不利。主症：脉浮、身重、汗出、恶风。治法：益气固表、利水祛湿。方剂：防己、黄芪、白术、甘草，配生姜、大枣；喘加麻黄，胃不和加芍药，气上冲加桂枝，下有陈寒加细辛。辨别点：自汗、恶风和虚脉是关键，不同于实邪无汗的麻黄类方。

桂枝附子汤、白术附子汤

证机：风湿相搏、阳气不足，关节疼烦而脉浮虚涩。主症：身体疼烦、不能自转侧；大便坚而小便自利者偏湿滞。治法：温经助阳、祛风除湿；后者加强白术利湿。辨别点：桂枝附子汤用于大便正常或不坚；大便坚、小便自利去桂枝加白术。服后身痹如冒是药力行皮中逐水的原文描述，不作不良反应自我判断。

甘草附子汤

证机：风湿深入关节、阳虚湿盛。主症：骨节疼烦掣痛、屈伸不利、近之痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或微肿。治法：温阳散寒、祛风除湿。方剂：甘草、白术、附子、桂枝。辨别点：以关节剧痛、湿阻和阳虚同见为度，附子为峻热药，须医者掌握炮制与剂量。

白虎加人参汤

证机：暑热入里，气津两伤。主症：汗出恶寒、身热而渴。治法：清热生津、益气。方剂：知母、石膏、甘草、粳米、人参。辨别点：不是无汗表寒；大渴、大热、汗出而气津虚才与纯白虎汤相应。

4.4 百合狐惑阴阳毒病脉证治第三：心神失养与湿热虫毒

百合病。百合病以“百脉一宗”而神志、饮食、睡眠和寒热感觉失常为核心：欲食不能食、欲卧不能卧、欲行不能行，口苦、尿赤，诸药误治反剧吐利。病位偏心肺阴液与百脉失和，治宜辨误汗、误下、误吐后的余势，不能一概清热或攻下。尿时头痛、头眩和愈期长短是病势观察，不是现代预后指标。

百合地黄汤

证机：未经汗、吐、下，百合病阴液受损、心肺失养。主症：病形如初，神情默默、饮食睡眠失常。治法：养阴清热、安神。方剂：百合、生地黄汁。辨别点：中病即止；服

后大便如漆为地黄色泽的条文描述，不宜与黑便出血混淆，实际出现黑便仍需就医。

百合知母汤、滑石代赭汤、百合鸡子汤

证机：分别对应误汗后余热伤阴、误下后胃气下逆夹水热、误吐后胃阴受损。主症：百合病基本神志饮食异常，兼口渴、心烦或胃气不和。治法：前者清热养阴，中者清利降逆，后者养胃和中。辨别点：关键在既往治疗史，先问汗、下、吐，再选方。

百合洗方、栝楼牡蛎散、百合滑石散

证机：久病津伤化渴或余热未清。主症：百合病一月不解而渴、渴不差或变发热。治法：外洗养阴、清热生津、利湿除热。辨别点：百合滑石散以微利为度，热除即止；不可把“利”理解为长期泻下。

甘草泻心汤

证机：狐惑湿热虫毒上蚀咽喉、下蚀阴部，兼中焦升降失常。主症：状如伤寒，默默欲眠而目不能闭，卧起不安，恶闻食臭，面色乍赤乍黑乍白；上部蚀则声音嘶哑。治法：和中清热、解毒扶正。方剂：甘草、黄芩、人参、干姜、黄连、大枣、半夏。辨别点：下部以苦参汤熏洗，肛蚀以雄黄熏；内服与外治按部位配合。

赤小豆当归散

证机：狐惑下部化脓，湿热瘀毒结聚。主症：脉数而无热、微烦默默、汗出，目赤后若能食提示脓已成。治法：排脓活血、利湿解毒。辨别点：“能食”在此为脓成的病势标志，不是一般食欲改善的泛指。

升麻鳖甲汤

证机：阳毒热毒入血，或阴毒寒凝血滞。主症：阳毒面赤斑如锦、咽痛唾脓血；阴毒面目青、身痛如被杖、咽痛。治法：解毒透邪、活血扶正。辨别点：阴毒去雄黄、蜀椒；原文以五日可治、七日不可治警示病势凶险，现代应按咽喉感染、败血症等急症处理。雄黄、鳖甲和蜀椒均不可自行使用。

4.5 疟病脉证治第四：寒热往来与疟母

疟脉以弦为常，弦数多热、弦迟多寒；弦小紧可下，弦迟可温，弦紧可汗或针灸，浮大可吐，弦数兼风则调节饮食。这里的“可”是辨证条件，不是固定流程。久疟结块为疟母，应在正气尚可时消积，不可急攻伤正。

鳖甲煎丸

证机：久疟邪正相搏，痰瘀、癥积互结。主症：疟母、胁腹结块，寒热反复日久。治法：软坚消积、活血化瘀、和解寒热。方剂：鳖甲配柴胡、黄芩、芍药、大黄、桃仁、牡丹皮、人参等多味，原方另载土鳖虫等虫类药。辨别点：只适合积久而正气未败的证候；虫类、攻下药及制备复杂，属于经典学习，不可自行配制。

白虎加桂枝汤

证机：温疟热盛兼营卫不和、经脉拘急。主症：脉平，身无寒但热，骨节烦疼，时呕。治法：清热生津、通阳解肌。方剂：白虎汤加桂枝。辨别点：有热无寒与牝疟的寒多相反；汗出热退为病势转机。

蜀漆散、牡蛎汤

证机：牝疟寒多，痰饮与伏邪相结。主症：寒多热少或但寒不热，发作有时。治法：涌吐痰饮、温阳截疟，或以牡蛎、麻黄、蜀漆和解。辨别点：蜀漆有刺激性，原文规定

发作前服；现只作方证认识。

柴胡去半夏加栝楼根汤、柴胡桂姜汤

证机：少阳枢机不利，疟久伤津或寒多微热。主症：前方用于疟病发渴、劳疟；后方用于寒多微热或但寒不热，初服微烦、继而汗出而愈。治法：和解少阳、清热生津；或温中通阳、和解寒热。辨别点：依据渴与寒热比例选方，不能把所有寒热往来都当作少阳疟。

4.6 中风历节病脉证并治第五：络经腑脏与痹痛

风邪入络先见肌肤不仁，入经则身重不胜，入腑则不识人，入脏则舌难言、口吐涎；半身不遂或单臂不遂属于痹，脉微数提示中风。寸口浮紧是寒虚相搏、血虚络空，邪气使缓、正气使急而成喎僻。历节则由汗出入水、肾骨肝筋失养，黄汗、关节剧痛、屈伸不利为特征。

侯氏黑散

证机：大风入络、四肢经脉失养，兼心中恶寒不足。主症：四肢烦重、麻木或风癫样发作。治法：祛风通络、温阳益气。辨别点：原文强调服后冷食、禁鱼肉大蒜，是古代服药法，不能照搬为现代饮食处方。

风引汤

证机：风热内动、痰火扰神、筋脉拘急。主症：瘫痫、瘈瘲，少儿惊痫日数十发。治法：清热熄风、镇痉。辨别点：抽搐、意识障碍须先排除癫痫持续状态、脑卒中和代谢性急症，不能自行按方服药。

防己地黄汤

证机：风邪扰神、血热或阴虚，神志失常而表无寒热。主症：如狂妄行、独语不休、脉浮。治法：祛风清热、养阴安神。方剂：防己、桂枝、防风、甘草浸酒，合生地黄汁。辨别点：“如狂”不是精神疾病诊断名，现代应先排除谵妄、躁狂、脑病和药物中毒。

桂枝芍药知母汤

证机：历节风湿痹阻，气血不利兼虚热、阳虚。主症：肢节疼痛、身体羸弱、脚肿如脱、头眩短气、欲吐。治法：祛风除湿、温阳通痹、滋阴清热。辨别点：多维配伍体现寒热错杂；与单纯寒湿关节痛须辨脉、汗和全身虚实。

乌头汤

证机：历节寒湿深入、经脉拘急。主症：关节不可屈伸、疼痛剧烈，亦治脚气疼痛。治法：温经散寒、止痛通痹。辨别点：川乌以蜜煎并严格控制服量，乌头中毒可危及生命，绝不可自制。

续命汤、三黄汤、术附汤、八味丸、越婢加术汤

辨证群：前两方偏中风痙、拘急疼痛兼气血不畅，后两方偏风虚头眩、肾阳不足及脚气上冲，越婢加术汤偏热盛津脱、下焦脚弱。治法：分别为解表通络、清热祛风、温阳补中、温补肾气、发汗利湿。辨别点：同为肢体无力，须区分风痙、湿热、阳虚和水湿；八味丸即肾气丸体系，附桂峻温，不能以“脚肿”一症套方。

4.7 血痹虚劳病脉证并治第六：营卫失和与虚劳内伤

血痹多见尊荣人骨弱肌盛，疲劳汗出、卧时受微风，脉微涩、寸关微而尺中小紧，病在阳气不行、肌肤失养。虚劳则包括失精、亡血、脾胃虚、阴血不足和久病气血俱亏，辨证要点是“脉大为劳，极虚亦为劳”以及里急、悸、衄、梦遗、酸疼、烦热等兼症。

黄芪桂枝五物汤

证机：血痹营卫俱微、阳气不达肌表。主症：身体不仁如风痹，寸关微、尺中小紧。治法：益气温经、和营通痹。方剂：黄芪、桂枝、芍药、生姜、大枣。辨别点：以麻木不仁而非剧烈疼痛为主，先针引阳气亦是原文治法。

桂枝加龙骨牡蛎汤、天雄散

证机：失精、心肾不固，阴阳失和。主症：少腹弦急、阴头寒、目眩、发落、男子遗精、女子梦交，脉芤动微紧。治法：调和营卫、潜阳固涩。辨别点：有清谷、亡血、极虚脉者须先辨虚损程度；天雄散用炮天雄，峻温有毒，仅作方名和治法学习。

小建中汤、黄芪建中汤

证机：中焦虚寒、营卫不足，虚劳里急。主症：腹中痛、心悸、衄血、梦遗、四肢酸疼、手足烦热、咽干口渴；黄芪建中汤兼诸不足、气短胸满。治法：温中补虚、和营缓急，黄芪建中汤再益气。辨别点：呕家因甘膩不宜小建中；腹满可去大枣加茯苓，气短胸满加生姜。

八味肾气丸

证机：虚劳肾阳不足、气化失司。主症：腰痛、少腹拘急、小便不利。治法：温补肾气、助膀胱气化。辨别点：与纯阴虚或湿热尿少相别，不能只凭腰痛使用。

薯蓣丸

证机：久虚气血阴阳俱不足，外受风邪而百病。主症：虚劳诸不足、羸弱、易感风气。治法：益气养血、调和营卫、扶正祛邪。辨别点：方味繁多、适合慢性虚损的整体调理，不能用于急性感染发热。

酸枣仁汤

证机：肝血不足、虚热扰心。主症：虚烦不得眠、心神不宁。治法：养血安神、清热除烦。方剂：酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草。辨别点：与痰热、实火失眠相别；失眠伴躁狂、呼吸暂停或严重抑郁须现代评估。

大黄土鳖虫丸

证机：五劳虚极、干血内结，肌肤甲错、两目黯黑。主症：羸瘦、腹满不能食，久病瘀血。治法：缓中补虚、逐瘀生新。辨别点：“缓中”表示丸剂缓攻，不是可以长期自行服用；大黄、虻虫、水蛭、土鳖虫等破血药须严禁自行使用。

炙甘草汤、獭肝散

证机：前方为气血阴阳俱虚、脉结代悸动；后方为冷劳或古称鬼疟。治法：前方益气养血、复脉；后方治冷劳，亦主古称“鬼疟”之证。辨别点：脉结代、胸闷晕厥应先排除心律失常；獭肝为动物药，现代不作常规自疗。

4.8 肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七：肺失宣降与肺脓

肺痿多由汗、吐、消渴、小便数、便难或峻下过度而津液重亡，表现为咳、浊唾涎沫，脉数而虚；肺痛则口燥、胸隐痛、脉滑数实，咳唾脓血，属于热毒壅肺。肺中冷、上虚不能制下可见吐涎沫、不渴、遗尿、小便数。咳嗽上气还需按脉浮沉、痰涎多少、胸水和喘鸣区分。

甘草干姜汤

证机：肺中虚冷、上虚不能制下。主症：肺痿吐涎沫而不咳、不渴，遗尿或小便数，眩而多涎。治法：温肺复气。辨别点：服后反渴转属消渴，提示寒证已变，不能继续温燥。

射干麻黄汤

证机：寒饮郁肺、痰气上逆。主症：咳而上气、喉中水鸡声。治法：宣肺散寒、化饮降逆。辨别点：哮鸣与寒饮明显，若高热脓血则转从肺痛论治。

皂荚丸

证机：痰浊壅肺、肺气上逆。主症：咳逆上气、频吐浊唾、坐不得眠。治法：祛顽痰、利肺气。辨别点：皂荚刺激性强，原方剂量极小，不能自行增量。

厚朴麻黄汤、泽漆汤

证机：咳嗽上气兼水饮，分别以脉浮、脉沉为辨。主症：浮脉偏表寒水饮，沉脉偏里饮结、久咳。治法：前方宣肺平喘、宽胸化饮；后方逐水扶正、降逆止咳。辨别点：脉浮沉是关键，不可只按咳嗽强度选方。

麦门冬汤

证机：肺胃阴虚、虚火上逆。主症：大逆上气、咽喉不利，久咳声哑、口干。治法：养阴生津、降逆止咳。辨别点：与寒饮咳喘相别；半夏少量配麦冬，体现“润中有降”。

葶苈大枣泻肺汤

证机：肺痛或支饮壅满，肺气闭塞、水饮壅盛。主症：肺痛喘不得卧，或支饮不得息、胸满浮肿。治法：泻肺逐水。辨别点：葶苈峻泻，虚人慎用；肺痛胸满浮肿原文先用小青龙汤一剂再进本方，体现先表后里。

桔梗汤、苇茎汤

证机：肺痛痰热脓毒壅塞。主症：胸满、振寒、脉数、咽干不渴、浊唾腥臭，久则吐脓如米粥；苇茎汤兼微热烦满、胸中甲错。治法：宣肺排脓、清热化痰。辨别点：咯脓血、发热和呼吸困难需要影像、抗感染及专科处理；桔梗白散含巴豆，原文仅作峻吐下的经典例。

越婢加半夏汤、小青龙加石膏汤

证机：肺胀外寒内饮或郁热，肺气上逆。主症：前方咳喘、目如脱、脉浮大；后方烦躁而喘、脉浮、心下有水。治法：宣肺泄热、化饮平喘。辨别点：前方石膏配麻黄偏热喘，后方兼细辛干姜五味子偏寒饮，需辨寒热虚实。

附方互参。炙甘草汤用于肺痿涎唾多而气血阴阳俱虚；生姜甘草汤用于咳唾涎沫不止而咽燥口渴，偏益气生津；桂枝去芍药加皂荚汤用于肺痿吐涎沫、痰浊壅肺；桔梗白散以桔梗、贝母、巴豆峻吐下肺痛脓毒，原文区分病在膈上则吐、膈下则泻。前三方仍须辨虚寒、津亏与痰浊，桔梗白散因含巴豆只宜作为经典峻剂认识。

4.9 奔豚气病脉证治第八：冲气与惊恐

奔豚不是单纯的腹部气胀，而是“从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止”的阵发性冲逆，条文强调多由惊恐触发。其病机可理解为肝肾冲气失调，寒水、痰饮或情志骤变使气机逆上；辨证重点是发作的起点、上冲路线及是否兼往来寒热、腹痛。

奔豚汤

证机：冲气上逆兼少阳郁热、寒热错杂。主症：气上冲胸、腹痛、往来寒热。治法：养血和营、平冲降逆、清少阳。方剂：甘草、川芎、当归、半夏、黄芩、葛根、芍药、生姜、甘李根白皮。辨别点：有往来寒热和腹痛才与单纯惊恐性气逆相应；突发胸痛、窒息、晕厥仍须排除心肺急症。

4.10 胸痹心痛短气病脉证治第九：上焦阳虚与痰饮瘀阻

胸痹的核心是“阳微阴弦”：上焦阳气不足，阴寒、痰饮或气结乘虚而上，故见胸痛、背痛、短气、喘息咳唾。辨证要分胸中痰饮、心中痞塞、寒凝剧痛与虚寒气短；同样是胸满，既可用通阳散结，也可用温中益气，取决于脉和全身虚实。

“阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。”

PDF 第 82 页（原书第 78 页）

栝楼薤白白酒汤

证机：胸阳不振，痰浊痹阻胸中。主症：喘息咳唾、胸背痛、短气，寸口沉迟、关上小紧数。治法：通阳散结、行气化痰。方剂：栝楼实、薤白、白酒。辨别点：胸阳虚、痰浊轻而偏胸痛者；若心痛彻背、不得卧，病势更重，改栝楼薤白半夏汤。

栝楼薤白半夏汤

证机：胸痹痰饮较重、上逆阻肺。主症：胸痹不得卧、心痛彻背。治法：通阳化饮、降逆止痛。辨别点：半夏增强化饮降逆，较前方适用于卧不安、痰饮明显者。

枳实薤白桂枝汤、人参汤

证机：前方为胸阳不通、气结痰阻；后方为中阳虚、寒湿上乘。主症：前方心中痞、胸满、胁下气逆抢心；后方胸痹而短气、气塞兼虚寒。治法：前方通阳散结、下气除满；后方温中益气。辨别点：痞满坚实、气逆明显用枳实薤白桂枝汤；面色少华、四肢冷、脉虚弱则偏人参汤。

茯苓杏仁甘草汤、橘枳姜汤

证机：胸中水饮或气滞，肺胃升降不利。主症：胸中气塞、短气；后方可见胸痹怫郁如满、噎塞、喉涩、唾沫。治法：利水降逆、理气宽胸。辨别点：前方偏水饮、脉虚，后方偏气滞痰阻、胸中满闷。

薏苡附子散

证机：胸痹阳虚湿滞，气机缓急不利。主症：胸痹缓急、疼痛时作。治法：温阳除湿、缓急止痛。辨别点：附子峻温，需有阳虚寒湿依据，不可用于阴虚火旺。

桂枝生姜枳实汤

证机：心阳不展、痰气上逆。主症：心中痞、诸逆、心悬痛。治法：温通心阳、降逆除痞。辨别点：痞痛与气逆并见，剂势较轻。

乌头赤石脂丸、九痛丸

证机：寒凝心脉、阳虚剧痛或久积冷邪。主症：心痛彻背、背痛彻心；九种心痛及冷冲上气。治法：温阳散寒、止痛破积。辨别点：乌头、附子、蜀椒、巴豆等均属峻烈或有毒药，古方丸剂只用于方证学习；现代胸痛首先排除急性冠脉综合征、主动脉夹层和肺栓塞。

4.11 腹满寒疝宿食病脉证治第十：虚实寒热与腑气通降

腹满按之不痛为虚，痛为实；时减复故多寒。趺阳微弦提示虚寒从下上，腹满兼发热、脉浮数而饮食如故则可能表里同病。寒疝以绕脐痛、手足厥冷、白汗出、沉弦脉为要点；宿食则脉数滑、下利而不欲食，或食在上脘而欲吐。攻下、温散、吐法必须严格按病位和正气取舍。

厚朴七物汤

证机：腹满里实兼表热，腑气不畅。主症：腹满发热十日、脉浮数、饮食如故。治法：解表和里、行气攻下。辨别点：呕加半夏，下利去大黄，寒多加生姜；是表里同治的代表。

附子粳米汤

证机：中焦寒气、胃肠失和。主症：腹中雷鸣切痛、胸胁逆满、呕吐。治法：温中散寒、和胃降逆。辨别点：腹痛喜温、脉沉迟与实热腹痛相别。

厚朴三物汤、大柴胡汤

证机：前方气滞腑实，后方为心下实满、枢机不利。主症：前方痛而闭；后方心下满痛、按之实。治法：前方行气除满、攻下；后方和解枢机、内泻热结。辨别点：本条以心下满痛、按之实为据；若兼往来寒热、胸胁苦满或呕，少阳阳明合病的特征更显，不能把所有腹痛都作里实攻下。

大建中汤

证机：中焦虚寒、阴寒上冲，阳气不通。主症：心胸大寒痛、呕不能食，腹中寒，上冲皮起、痛不可触。治法：温中补虚、降逆止痛。方剂：蜀椒、干姜、人参，加胶饴。辨别点：痛剧而喜温、寒象显著；蜀椒干姜辛热，须防热伤阴。

大黄附子汤

证机：寒实积滞，阳虚而里结。主症：胁下偏痛、发热、脉紧弦。治法：温阳散寒、攻下积滞。辨别点：“温药下之”体现寒实夹阳虚，区别于单纯热结的大承气汤。

赤丸

证机：寒气厥逆、痰饮内停。主症：厥冷、腹痛、气逆。治法：温阳逐饮、降逆。辨别点：乌头、朱砂等药峻烈，经典学习不等于现代可用。

大乌头煎、乌头桂枝汤

证机：寒疝寒邪深入、经脉拘急；后方兼表里寒、气血不和。主症：绕脐剧痛、手足厥冷、沉弦脉；或寒疝腹痛、逆冷、身痛而诸药不效。治法：蜜煎乌头温经止痛，乌头桂枝汤以桂枝汤调和营卫并缓投乌头。辨别点：服后“如醉”“得吐”是古代中病描述，乌头中毒风险极高，严禁自行试服。

当归生姜羊肉汤

证机：寒疝腹痛、血虚寒凝，兼虚劳不足。主症：腹中痛、胁痛里急、逆冷。治法：温

中养血、散寒止痛。辨别点：寒多加生姜，痛多呕加橘皮白术；与大建中汤相比，血虚和产后虚寒更突出。

宿食诸方

证机与治法：脉数滑、下利不欲食为宿食在里，宜大承气汤；宿食在上脘宜瓜蒂散催吐；脉紧如转索提示食积。辨别点：瓜蒂散对虚弱、亡血者禁用，催吐、峻下均须专业监护。

附方互参。《外台》柴胡桂枝汤用于心腹卒痛而兼太阳少阳不和；《外台》乌头汤用于寒疝绞痛、手足厥逆；走马汤以杏仁、巴豆治中恶心痛、腹胀便秘。三方分别体现和解、温散与峻下，尤其巴豆、乌头毒性显著，只作古方比较。

4.12 五脏风寒积聚病脉证并治第十一：着、积、聚与三焦寒热

肝着表现为胸中气滞、喜蹈胸、喜热饮，属络中瘀滞；肾着是寒湿下着腰部，腰以下冷痛、身重如带五千钱而小便自利。三焦寒热的条文把上焦咳、肺痿，中焦坚满，下焦尿血淋秘联系起来，并以大肠、小肠寒热解释溏泄、肠垢、便血与痔。积为脏病而固定，聚为腑病而时聚时散；“谷气”一词在 PDF 中为缺字，按通行本理解为胁下痛、按之暂愈而复发。

旋覆花汤

证机：肝着、胸胁气血痹阻。主症：常欲蹈胸，先喜热饮。治法：行气活血、通络除痹。方剂：旋覆花、葱、新绛。辨别点：胸痛而喜温、无明显痰热；胸痛伴压榨感或活动诱发仍须现代心血管评估。

甘姜苓术汤

证机：肾着寒湿，阳气不行于下焦。主症：身体重、腰中冷如坐水，小便自利、不渴、饮食如故。治法：温阳健脾、淡渗利湿。辨别点：腰以下冷痛而非肾虚腰酸；小便自利正是水湿停着而气化尚存的提示。

4.13 痰饮咳嗽病脉证并治第十二：四饮与水饮出路

四饮的分型是本篇核心：痰饮为水走肠间、沥沥有声；悬饮为水留胁下、咳唾引痛；溢饮为水流四肢、身体沉重而汗不出；支饮为咳逆倚息、短气不得卧、形如肿。病痰饮总原则是“当以温药和之”，但水饮既可从小便、汗、吐、下而出，也可因误治更结，故必须观察脉、渴、呕、肿和病位。

“病痰饮者，当以温药和之。”

PDF 第 87 页（原书第 83 页）

苓桂术甘汤

证机：脾阳不足，水饮停于心下。主症：胸胁支满、目眩、短气，脉偏弦或沉。治法：温阳健脾、利水降冲。辨别点：小便利则效；短气有微饮也可用，肾气丸则偏肾阳不足。

甘遂半夏汤、十枣汤

证机：前方留饮欲去而心下续坚满，后方悬饮水停胁下。主症：脉伏、下利反快而心下仍坚；或胸胁引痛、咳唾。治法：峻逐水饮。辨别点：甘遂、芫花、大戟皆峻下逐水，先评估正气、肾功能与电解质；服后只能在专业监护下观察。

大青龙汤、小青龙汤

证机：溢饮外束，分别偏风寒郁热和寒饮内停。主症：身重、四肢水肿、无汗；小青龙偏咳喘、痰稀、恶寒。治法：发汗解表、温化水饮；大青龙兼清郁热。辨别点：大青龙汗力峻，汗多须止；小青龙以干姜细辛五味子温化寒饮，阴虚燥咳不宜。

木防己汤及去石膏加茯苓芒硝汤

证机：膈间支饮，饮停气逆、心下痞坚。主症：喘满、面黧黑、脉沉紧，数十日不愈；虚者一剂而愈，实者三日复发。治法：通阳利水、补虚逐饮；复发实证去石膏加茯苓芒硝微利。辨别点：“虚者即愈、实者复发”提示不能只重复原方，应重新辨虚实。

泽泻汤、厚朴大黄汤、葶苈大枣泻肺汤

证机：支饮上冒、胸满或喘不得息。主症：心下支饮而冒眩；支饮胸满；支饮不得息。治法：分别利水降眩、行气除满、泻肺逐水。辨别点：眩以水饮上泛为主用泽泻汤；胸满便秘可考虑厚朴大黄汤；喘迫浮肿才用葶苈泻肺。

小半夏汤、小半夏加茯苓汤

证机：胃中水饮、胃气上逆。主症：呕家本渴而今不渴、心下支饮；卒呕吐、心下痞、眩悸。治法：温胃化饮、降逆止呕；后方兼利水安悸。辨别点：先渴后呕多为水停，呕后渴而思水则将解，病机顺序比单一症状更重要。

己椒苈黄丸、五苓散

证机：肠间水气、气化不利。主症：腹满、口舌干燥，或瘦人脐下悸、吐涎沫、眩。治法：前方泻肺逐水、行气除满；后方利水渗湿、通阳化气。辨别点：己椒苈黄丸偏水结腹满，原方渴者另有加芒硝法；五苓散偏膀胱气化不利，大黄、葶苈和桂枝均须辨证。

茯苓饮

证机：停痰宿水，吐水后中焦虚、气满不能食。主症：心胸虚满、食欲不振。治法：健脾化痰、和胃行气。辨别点：适合“吐水后虚”而非实满，体现攻后顾护中气。

青龙汤后调治诸方

证机：小青龙汤后冲气、咳满、渴、呕或形肿的阶段性变化。主症：分别见气从小腹冲胸、咳满、渴反止而冒呕、形肿、面热如醉。治法：依次用茯苓桂枝五味甘草汤、苓甘五味姜辛汤、加半夏汤、加杏仁汤、加大黄汤，分别治冲气、寒饮咳满、支饮呕、表水形肿和胃热上冲。辨别点：这是随证加减的连续示范，强调“水去、呕止、冲气低”后仍要重新辨证，不可原方久服。

4.14 消渴小便不利淋病脉证并治第十三：气化、津亏与淋证

消渴从脉象解释：寸口浮迟为虚劳、卫营不足，趺阳浮数为胃气盛而消谷、溲数；小便频数使津液偏渗，继而大便坚，形成“溲数与便坚相搏而成消渴”的病机。男子饮一斗尿一斗属肾气虚，条文以肾气丸主之。淋证以尿如粟、小腹弦急、痛引脐中为要；小便不利兼渴，需辨水气、阳虚与湿热。

肾气丸

证机：肾阳不足、膀胱气化无力，兼阴精亏。主症：消渴而小便反多，或小便不利、转胞不得溺。治法：温补肾气、助气化行水。辨别点：口渴多饮伴尿多、腰膝酸软偏虚；湿热淋证有尿痛、尿赤、脉数者不宜温补。

文蛤散

证机：津伤燥渴，水热互结较轻。主症：渴欲饮水不止。治法：清热化痰、生津止渴。
辨别点：只有单纯渴证时方可讨论，持续口渴须排查糖代谢、脱水和肾病。

栝楼瞿麦丸

证机：下焦阳虚、水气不化而津不上承。主症：小便不利兼渴，腹中冷。治法：温阳利水、生津润燥。辨别点：以“小便利、腹中温”为效应观察；附子为温阳峻药。

蒲灰散、滑石白鱼散、茯苓戎盐汤

证机：淋证或小便不利中的湿热、瘀阻、脾肾气化不足。治法：分别清利湿热、通淋化瘀、健脾利水兼软坚。辨别点：尿血、尿痛、发热或腰痛须排除泌尿系感染、结石和肾损伤，不能以散剂自疗。

4.15 水气病脉证并治第十四：五水、上下出路与黄汗

五水分型：风水脉浮、骨节痛恶风；皮水脉浮、四肢按之没指、不恶风；正水脉沉迟而喘；石水脉沉、腹满不喘；黄汗脉沉迟、发热汗黄、胸满肿胀。总原则是“腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗”。血分与水分要看月经先后：经先断后病水为血分，水先病后经断为水分，治法和难易不同。

防己黄芪汤

证机：风水表虚、脾虚水湿。主症：脉浮身重、汗出恶风；腹痛可加芍药，腰以下肿、阴部肿和屈伸不利亦见。治法：益气固表、利水除湿。辨别点：自汗恶风而无大热是关键，与实表无汗的越婢汤相别。

越婢汤、越婢加术汤、甘草麻黄汤

证机：风水或里水、表实水肿，肺气不宣。主症：一身悉肿、脉浮、不渴、恶风或小便不利；里水面目黄肿、脉沉。治法：宣肺发汗、清热利水；加术增强健脾除湿，甘草麻黄汤力较简。辨别点：恶风汗出有热偏越婢；里水脉沉偏越婢加术；虚胀无水属气，不宜发汗。

防己茯苓汤

证机：皮水停于肌肤，阳气不行。主症：四肢肿，水气在皮肤，四肢聂聂动。治法：益气通阳、利水消肿。辨别点：按之没指而不恶风，区别于风水。

麻黄附子汤、杏子汤

证机：水病属少阴阳虚或表有风。主症：脉沉小、身体肿重；脉浮则偏风。治法：沉脉用麻黄附子汤温阳发汗，浮脉用杏子汤宣肺利水。辨别点：无水虚胀为气，不能误当水病发汗。

黄芪芍药桂枝苦酒汤

证机：汗出入水，水从汗孔入，营卫不和而湿热郁表。主症：黄汗、身肿发热、汗沾衣色黄如柏汁、渴，脉沉。治法：益气和营、利湿解肌。辨别点：服后心烦是苦酒阻滞的条文反应；黄汗伴肝胆异常、感染或肾病须现代检查。

桂枝加黄芪汤

证机：黄汗日久，营卫不和、表虚湿滞，兼劳气。主症：汗出后反发热、身重、腰以上汗而以下无汗、腰髋弛痛，小便不利。治法：调和营卫、益气固表、微汗除湿。辨别点：要求温服并饮热稀粥助汗，不能大汗耗津。

桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤、枳术汤

证机：气分水饮，心下坚大如盘。主症：前方边如旋杯、表阳不足兼寒饮；后方心下坚满、边如旋盘。治法：前方温阳发汗逐水，后方健脾行气消痞。辨别点：前方有表寒、脉浮等，后方偏中焦痞实；两方均不是一般胃胀的通用方。

附方。厥而皮水者用蒲灰散，取蒲黄类药与滑石化瘀通淋、利水；原文仅给简短方证，应与风水、皮水及尿血淋证合参。

4.16 黄疸病脉证并治第十五：湿热、寒湿与三类黄疸

黄疸的共同病机是湿邪与瘀热相搏、脾失运化，辨证需分谷疸、女劳疸（黑疸）和酒疸。谷疸寒热不食、食即头眩、心胸不安；女劳疸额黑、足热、膀胱急，小腹如水状为难治；酒疸心中懊憹、热痛、欲吐。治黄原则是利小便；脉浮者可从表解，腹满小便赤而自汗则表和里实，应下。

茵陈蒿汤

证机：谷疸湿热郁结，胆汁外溢。主症：寒热、不食、食即头眩、心胸不安，久则全身黄。治法：清热利湿、通腑退黄。辨别点：小便利、尿色转赤黄是湿热外泄的观察点；黄疸伴意识障碍或出血须急诊。

硝石矾石散

证机：女劳疸日久，湿热与瘀血结于下焦。主症：日晡发热恶寒、膀胱急、少腹满、额黑、足下热，腹胀如水、大便黑。治法：消积逐瘀、利湿退黄。辨别点：硝石、矾石为峻烈矿物药，现代不可自用；黑便需先排除消化道出血。

栀子大黄汤

证机：酒疸湿热壅滞、胃肠不利。主症：心中懊憹，或热痛。治法：清热除烦、泻下退黄。辨别点：饮酒史与热象明显，虚寒黄疸不宜。

桂枝加黄芪汤、猪膏发煎、茵陈五苓散

证机：前方为黄疸兼表虚，猪膏发煎为诸黄湿滞，茵陈五苓散为湿热与水气并见。主症：脉浮或汗出、黄疸小便不利。治法：分别解肌益气、润燥利尿、利湿化气。辨别点：小便通利是各方共同观察点，不能以肤色深浅单独判断。

大黄硝石汤、柴胡汤、小建中汤、麻黄醇酒汤

证机与治法：腹满、小便不利而赤、自汗为表和里实，用大黄硝石汤清热通腑；黄疸腹痛而呕从少阳和解，用柴胡汤；男子黄而小便自利、属虚劳者用小建中汤；麻黄醇酒汤则是《千金》所载治黄疸单方，原条信息极简。辨别点：方证分别落在里实、少阳、虚劳及泛称黄疸，不能脱离具体证候混用或自行扩用。

4.17 惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六：血逆与瘀阻

本篇将“胸满、口燥而漱水不欲咽、唇舌青、脉微大迟”视为瘀血，而不是单纯热证；若表面似热而脉无热，亦要想到阴伏瘀血。吐血、衄血和便血再按出血先后定位：先便后血为远血，先血后便为近血。治法分别采用温中摄血、清泻心火、活血下瘀，不能把所有出血都当作“热迫血行”。

“病人胸满，唇痿舌青，口燥，但欲漱水不欲咽，无寒热……为有瘀血。”

PDF 第 95 页（原书第 91 页）

半夏麻黄丸

证机：水饮上逆、心阳不宁。主症：心下悸。治法：化饮降逆、通阳定悸。辨别点：心悸伴胸痛、晕厥或脉极不整需现代心电评估。

柏叶汤

证机：中焦虚寒、血不归经。主症：吐血不止。治法：温中止血。辨别点：适用于寒象和虚象，鲜红大量呕血不能等待自服汤剂。

黄土汤

证机：脾阳虚寒、统血无权。主症：先便后血（远血），亦治吐血、衄血；可见面色少华、腹痛喜温。治法：温阳健脾、养血止血。辨别点：附子、灶中黄土为温涩之意；脉数有力、口渴便秘的实热出血不宜。

赤小豆当归散

证机：近血，肠道湿热瘀滞。主症：先血后便。治法：利湿活血、排瘀止血。辨别点：与黄土汤的远血、虚寒相反，需看血与粪的先后关系。

泻心汤

证机：心气不足而心火迫血妄行。主症：吐血、衄血，兼心烦、口舌生疮或脉数。治法：苦寒泻火、凉血止血。辨别点：大黄、黄连、黄芩为苦寒攻泄，虚寒出血不宜。

4.18 呕吐哕下利病脉证治第十七：胃气上逆与水谷失调

呕吐的辨证先看渴的先后：先呕后渴多为欲解，先渴后呕为水停心下；呕家本渴而反不渴，提示支饮。趺阳浮涩、朝食暮吐或暮食朝吐、宿谷不化为胃反，脉紧涩则难治。下利气者当利小便；下利而三部脉平、心下坚满属里实，须急下。治疗始终围绕和胃降逆、温中化饮、利水和通腑。

茱萸汤

证机：胃寒浊逆、肝胃不和。主症：呕而胸满，或头痛、吐涎、手足厥。治法：温中散寒、降逆止呕。辨别点：吴茱萸辛热，阴虚胃热呕吐不宜。

半夏泻心汤

证机：寒热错杂、中焦痞满、升降失常。主症：呕而肠鸣、心下痞。治法：和胃降逆、辛开苦降、益气。辨别点：痞满不痛、寒热并见，与单纯胃热或寒凝相别。

小半夏汤、猪苓散

证机：前方胃中水饮，后方吐后膈上余饮、津液不布。主症：诸呕吐谷不得下；呕吐后思水而饮不解。治法：温胃化饮；利水渗湿。辨别点：渴的时序是选择依据。

大半夏汤

证机：胃反久吐，中虚有饮、胃气不降。主症：食入即吐、心下痞硬、不受食。治法：和胃降逆、润燥补虚。辨别点：半夏配人参、白蜜，适合虚而不实；持续体重下降须查器质性梗阻。

大黄甘草汤

证机：食积化热、胃肠腑气不通。主症：食已即吐，亦治吐水。治法：通腑泄热、降

逆止呕。辨别点：必有里实、便秘或积滞倾向，虚寒胃反不宜。

茯苓泽泻汤

证机：胃反吐后，水饮停中，阳气不化。主症：吐而渴欲饮水，饮后更吐。治法：利水和胃、温阳降逆。辨别点：与单纯津亏口渴相别，重在水饮停留。

文蛤汤

证机：吐后水热互结、表有微风。主症：吐后渴欲贪饮，兼脉紧头痛。治法：清热利水、疏表止渴。辨别点：兼表证才用，不能用于糖尿病单纯口渴。

半夏干姜散、生姜半夏汤、橘皮汤、橘皮竹茹汤

证机：前三方分别为寒饮干呕、胸中气逆似喘似呕、胃寒哕逆；橘皮竹茹汤为胃虚有热、哕逆。治法：温中化饮、降逆和胃，或清胃止哕。辨别点：手足厥、涎沫多偏寒；口渴、虚烦、久哕偏胃虚有热。

大承气汤、紫参汤、诃梨勒散

证机与治法：下利而心下坚满、三部脉平为里实，宜大承气汤急下；紫参汤仅据原文“下利肺痛”保留方证，病机未详且原文自疑非仲景方；气利、滑泄而无明显热结可用诃梨勒散。辨别点：先判断是实热、虚寒或气滞，勿以“腹泻”一症泛用攻下，也不可把“肺痛”直接等同于肺痈。

附方互参。《千金翼》小承气汤治大便不通、哕数谵语，属腑实气滞；《外台》黄芩汤治干呕下利，以黄芩清热而配人参、干姜、桂枝、半夏和中，体现寒热错杂。两者一攻一和，以心下坚满、便秘与下利的虚实为界。

4.19 疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八：脓成与否

浮数脉本应发热，反洒淅恶寒且有固定痛处，提示痈将成；以手按肿上，热为有脓，不热为无脓。肠痈的身甲错、腹皮急而按之濡、无积聚、脉数，说明腹内已有脓，但脓未成与已成的处置完全不同：脉迟紧、少腹肿痞且按痛可下，脉洪数则脓成，禁下。

薏苡附子败酱散

证机：肠痈初成，湿热瘀毒内结而脓未盛。主症：身甲错、腹皮急、按之濡如肿状，无热、脉数。治法：排脓解毒、温阳化湿。辨别点：小便利为湿毒外出观察点；腹痛加剧、发热高或休克须急诊。

大黄牡丹汤

证机：肠痈脓未成而瘀热结于少腹。主症：少腹肿痞、按之即痛如淋，小便自调，时发热自汗恶寒；脉迟紧。治法：泻热破瘀、消痈排脓。辨别点：脉洪数、脓已成不可下；现代需影像和外科会诊，不能以汤剂代替引流。

王不留行散

证机：金疮或外伤后气血瘀滞、创口不利。主症：金刃伤，亦载产后可服。治法：活血止痛、生肌。辨别点：创伤首先清创、止血和防破伤风；方中川椒等炮制要求复杂。

排脓散、排脓汤

证机：痈脓已成或脓毒在肺肠。主症：脓肿、脓血、胸满咳脓等。治法：排脓解毒、宣肺和营。辨别点：是辅助排脓方，不能替代切开引流和抗感染。

4.20 跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九：本节录条

本 PDF 在该篇只录入“阴狐疝”和“蛔虫”两组条文，标题前列的跌蹶、手指臂肿、转筋并未见具体条文，以下不臆补。阴狐疝为阴器偏坠、大小不一、时上时下，属寒凝气机；蛔虫病则吐涎、心痛、发作有时，毒药不止时以甘草粉蜜缓和驱虫。

蜘蛛散

证机：阴狐疝寒凝、气机升降失常。主症：阴囊偏有大小、时时上下。治法：温肝散寒、行气止痛。辨别点：需排除嵌顿疝、睾丸扭转等急症；蜘蛛、桂枝为古方特殊药材。

甘草粉蜜汤

证机：蛔虫扰动、胃肠痉挛。主症：吐涎、心痛、发作有时，峻毒药仍不止。治法：和中缓急、安蛔止痛。辨别点：现代应先行粪检、影像和驱虫规范治疗；腹痛伴呕血、腹膜刺激征须急诊。

4.21 妇人妊娠病脉证并治第二十：冲任、胞宫与妊娠用方

妊娠的诊断线索为平脉而阴脉小弱、口渴不能食、无寒热；妊娠期出现漏下、腹痛、呕吐、小便难和水气，均要先辨胎、癥、胞阻及脾肾气化。宿有癥病而漏下不止，胎动脐上，说明癥瘕妨胎，治宜缓消而非猛烈攻下；妊娠腹痛可因胞阻、血虚、寒凝或水湿，方证各异。

桂枝汤

证机：妊娠早期营卫不和、冲气上逆。主症：平脉而阴脉小弱、口渴不能食、无寒热，约六十日可见。治法：调和营卫、和胃安胎。辨别点：本条兼作妊娠识别，若此前误治吐下则证候可提前或中断；不能把桂枝汤当妊娠试验。

桂枝茯苓丸

证机：妊娠宿癥、瘀阻冲任，胎与癥并见。主症：经断未足三月而漏下不止、胎动脐上，或癥瘕妨胎。治法：活血化瘀、消癥安胎。辨别点：丸剂小量、渐进，须严格排除宫外孕和流产；妊娠出血不可自行服活血药。

附子汤

证机：妊娠六七月，子脏虚寒、胎胀腹痛。主症：脉弦发热、胎愈胀、腹痛恶寒、少腹如扇。治法：温暖胞宫。辨别点：原文仅载方名未载方剂组成，属于 PDF 收录但信息不全的条文，不据后世方补写。

胶艾汤（芎归胶艾汤）

证机：冲任虚损、血不固摄。主症：漏下、半产后续下血不绝，妊娠腹痛为胞阻。治法：养血止血、调冲安胎。辨别点：出血量大、头晕心悸或腹痛剧烈须急诊，不能以艾叶阿胶自疗。

当归芍药散

证机：妊娠血虚夹水湿、脾失运化。主症：妊娠腹中绵绵作痛（原 PDF 方框字），或妇人腹中诸疾痛。治法：养血调肝、健脾利湿。辨别点：与胶艾汤的出血证相别；腹痛伴发热、压痛或阴道流血须排除急症。

干姜人参半夏丸

证机：妊娠中焦虚寒、痰饮上逆。主症：妊娠呕吐不止。治法：温中益气、化饮止呕。

辨别点：少量频服，注意脱水、电解质和妊娠剧吐风险。

当归贝母苦参丸

证机：妊娠下焦湿热或气化不利。主症：小便难而饮食如故。治法：养血润燥、清利湿热。辨别点：男子用时原文加滑石；妊娠尿痛发热需查感染，不能只作“胎压膀胱”。

葵子茯苓散

证机：妊娠水气、脾肾气化不利。主症：身重、小便不利、恶寒、起则头眩。治法：利水通窍、健脾。辨别点：以小便利为效；妊娠水肿伴高血压、蛋白尿须警惕子痫前期。

当归散、白术散

证机：前方为妊娠血虚、脾弱，后方为养胎脾胃不和、寒湿。主症：前方用于常服养胎、易产；后方用于胎养，兼腹痛、心下毒痛、烦吐不能食等加减。治法：养血健脾、调和冲任；白术散兼温中安胎。辨别点：“常服易产”是古代经验语境，不能替代现代产检；蜀椒、牡蛎等药须由医者审核。

4.22 妇人产后病脉证治第二十一：血虚、亡津与瘀血

新产三病的病机高度概括：血虚多汗、易中风而痉；亡血复汗、寒多而郁冒；亡津液、胃燥而大便难。产后腹痛还要区分寒疝虚劳、气血壅滞、干血着脐下和恶露不尽；产后风若数十日仍有阳旦证，可按桂枝汤体系辨治。乳中虚、烦乱呕逆属气血不足与虚热，产后下利虚极则脾肾受损。

“新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难。”

PDF 第 101 页（原书第 97 页）

当归生姜羊肉汤

证机：产后血虚、寒凝中焦，兼虚劳不足。主症：产后腹中绵绵冷痛，也治寒疝腹痛。治法：温中养血、散寒止痛。辨别点：与枳实芍药散的气滞烦满、下瘀血汤的干血相别。

枳实芍药散

证机：产后气血壅滞、腹中急痛。主症：腹痛、烦满不得卧。治法：行气和血、缓急止痛。辨别点：枳实烧黑但勿太过；无效且脐下有固定痛再考虑下瘀血汤。

下瘀血汤

证机：产后干血着脐下，恶露不尽。主症：腹痛固定、按之不缓，亦治经水不利。治法：破血逐瘀。辨别点：大黄、桃仁、土鳖虫峻破，产后出血未止、贫血或哺乳期不能自行服。

大承气汤

证机：产后恶露不尽兼阳明腑实，热结膀胱。主症：产后七八日少腹坚痛、不大便，日晡烦躁发热，进食则谵语，至夜稍愈，脉微实。治法：峻下热结。辨别点：必须有里实便秘、谵语；与单纯产后血虚便难相别。

阳旦汤（桂枝汤）、竹叶汤

证机：前方为产后风表虚、营卫不和；后方为产后中风、风热上扰兼气血虚。主症：前方头微痛、恶寒、时热、心下闷、干呕汗出；后方发热面赤、喘、头痛。治法：调和营

卫、解肌；竹叶汤兼清热益气、温阳扶正。辨别点：颈项强、呕吐分别有附子、半夏加減，仍須排除产后感染和肺栓塞。

竹皮大丸、白头翁加甘草阿胶汤

证机：前方乳中虚、虚热上扰；后方产后下利日久、气血阴液俱虚。主症：烦乱呕逆；下利虚极。治法：前方安中益气、清热除烦；后方清热止利、养血固脱。辨别点：产后腹泻伴发热、血便或脱水需检查感染和出血。

三物黄芩汤、内补当归建中汤

证机与治法：三物黄芩汤治产褥受风、四肢烦热；内补当归建中汤治产后虚羸、腹中刺痛、少气和少腹急痛，出血过多可加地黄、阿胶。辨别点：前方偏风热烦热，后方偏血虚中寒，須辨有无汗出、恶寒和失血。

4.23 妇人杂病脉证并治第二十二：气郁、血瘀与胞系

妇人杂病条文把咽中异物感、脏躁、带下、经水不利、少腹积水血、阴中疮和阴吹等纳入同一辨证体系。情志与痰气互结可成梅核气；脏躁为心脾不足、神失所养；半产瘀血留少腹可见带下、午后发热和掌烦热；转胞则是胞系了戾、气化不利，利小便为治疗要点。妇科症状与全身气血水液相互牵连，不能只作局部病处理。

半夏厚朴汤

证机：痰气互结、肺胃失降，情志郁结。主症：咽中如有炙脔，咽之不下、吐之不出。治法：行气解郁、化痰降逆。辨别点：需排除咽喉器质性病变、甲状腺和反流；“梅核气”是证候名而非心理化标签。

甘麦大枣汤

证机：心脾气血不足、神志失养。主症：脏躁，悲伤欲哭、数欠伸、象如神灵所作。治法：养心安神、补脾缓急。辨别点：不能替代对抑郁、双相障碍、癫痫和创伤后症状的评估。

温经汤

证机：冲任虚寒、瘀血内阻、阴血不足。主症：年五十左右久利，暮发热、少腹急满、掌烦热、唇口干；亦治少腹寒、久不受胎、崩中和月经失调。治法：温经散寒、养血祛瘀、调冲任。辨别点：寒热错杂、虚实并见，不能以“发热”单用清热药。

土瓜根散

证机：带下、经水不利，少腹瘀滞。主症：少腹满痛、经期一月再见；亦载阴部肿痛（原 PDF 此处为方框字，字形不清）。治法：活血通经、消癥止痛。辨别点：桂枝、芍药配土瓜根和土鳖虫，妊娠及出血者禁忌需由医者判断。

胶姜汤（方缺）

证机：陷经、漏下黑血不解，疑为胶艾汤类冲任虚损。主症：漏下黑不止。治法：仅据条文可概括为养血止漏；PDF 明确无方，不能擅自补方。

大黄甘遂汤

证机：水血并结血室，瘀血阻于少腹。主症：少腹满如敦、小便微难而不渴，产后或经后出现。治法：逐水破瘀、通下。辨别点：大黄、甘遂、阿胶峻缓相济，妊娠、贫血和肾病患者不可自用。

抵当汤

证机：蓄血、瘀血闭阻胞宫或膀胱。主症：经水不利；亦治男子膀胱满急有瘀血。治法：破血逐瘀。辨别点：水蛭、虻虫、桃仁、大黄皆破血峻剂，须先排除妊娠及活动性出血。

矾石丸

证机：经闭日久、脏坚癖结，中有干血并下白物。主症：经水闭不利、腹内坚癖。治法：燥湿破结、化瘀。辨别点：内置丸剂为古代特殊给药法，矾石、杏仁有毒性和刺激性，绝不可照法自施。

红蓝花酒、当归芍药散、小建中汤

证机与治法：红蓝花酒治妇人血气刺痛、诸风；当归芍药散治妇人腹中诸疾病、血虚水湿；小建中汤治腹中虚寒挛痛。辨别点：同为腹痛，须分瘀血、血虚水湿和中焦虚寒，不能以“痛”一症混方。

肾气丸

证机：转胞，胞系了戾、肾气不足，膀胱气化不利。主症：饮食如故、烦热不得卧而倚息、不能溺，小便不利。治法：温补肾气、利小便。辨别点：尿潴留、下腹胀痛需先导尿和排除机械性梗阻，不能延误。

蛇床子散、狼牙汤、膏发煎

证机与治法：蛇床子散温阴中；狼牙汤清洗阴中蚀疮；胃气下泄、阴吹正喧为谷气实，原文作膏发煎导之（与猪膏发煎同类）。辨别点：阴部溃疡、异味、疼痛需妇科检查和感染筛查，古代熏洗、内置和导法不可自行照搬。

4.24 综合辨证与临床学习要点

1. 先定病位，再定出路。痰饮可从汗、吐、下、利小便而出；水肿按上下分汗法与利尿法；出血按远近、寒热、虚实定治法。症状相同而病位不同，方剂完全不同。
2. 方证是动态序列。小青龙汤后冲气、咳满、渴、呕、形肿的连续加减，以及百合病误汗、误吐、误下后的分别处理，显示经典重视“治疗之后的再辨证”。
3. 攻邪必顾正气。大承气汤、十枣汤、甘遂半夏汤、抵当汤、乌头汤等都以特定病位和脉证为前提；条文中的“可下”“得下止服”“微利则愈”都是剂量和疗程边界。
4. 妇科不离脾肾与冲任。妊娠腹痛、产后腹痛和经闭都可能由寒、瘀、水、虚互结，不能只按月经或妊娠标签选方。现代妊娠、产后患者应优先接受产科风险评估。
5. 经典病名与现代病名不可硬对应。“肺痿”“胸痹”“奔豚”“狐惑”“转胞”等是古代证候和病机范畴，可启发问诊与辨证，但不能替代影像、实验室、心电图、超声和专科诊断。

4.25 校勘说明

- PDF 第 70 页“饪之邪”首字为古本异体或 OCR 缺字；本文按上下文写作“饮食之邪”，不把该处当作可靠的逐字引文。
- PDF 第 70 页栝楼桂枝汤条有两个连续方框字，据通行本校为“几几然”；表示项背强急、俯仰不利的状态。

- 多页方剂制法中的“咀”前有方框字，是古代药物切碎术语的字形/OCR 缺失，本文概括为“切碎”；不影响方证内容。
- PDF 第 75、79、101、103 页多处虫类药名有方框字，均据方名和通行本校为土鳖虫，正文不强行使用生僻异体字。
- PDF 第 76、79 页川芎药名出现字体私用区字形，按药名校为“川芎”。
- PDF 第 87 页胁下痛条的病名有方框字，按通行本和“按之则愈、复发”校作“谷气”；正文说明该处仍存版本差异。
- PDF 第 100、101 页“腹中”后为古字方框，正文改写为“绵绵作痛”或“拘急痛”，避免把不可识字形误当现代“绞痛”。
- PDF 第 103 页“阴”后为方框字，正文只作“阴部肿痛”意译，不据此恢复具体古字。
- PDF 第 104 页末条“膏发煎”与前文“猪膏发煎”相承，正文以“猪膏发煎同类”说明；该页随后进入“温病学篇”，后续文字及《温热论》已从本节《金匱要略》笔记中排除。
- 个别剂量、炮制及校语在 PDF 中采用古制或异文（如“白鱼”“戎盐”“去上沫”等），本文只在方证层面归纳，未将古制剂量转换为现代处方剂量。

5、 温病学篇：从卫气营血到三焦辨治

5.1 全篇定位与阅读主线

本篇覆盖 PDF 第 104–129 页（原书第 100–125 页），不是一部单一著作的节录，而是以叶天士《温热论》、薛生白《湿热病篇》和吴鞠通《温病条辨》为主体，并参合《杂说治病法论》《瘟疫论》《广瘟疫论》《伤寒瘟疫条辨》《疫疹一得》《通俗伤寒论》等文献。阅读时宜把零散条文还原为四条互相校验的主线：

1. 邪从何入、停在何处：温邪多从口鼻而受，先犯肺卫；湿热多困阳明、太阴并牵涉三焦；疫邪则可伏于膜原。病位判断决定辛凉透表、芳香宣化、分消走泄、清营凉血或攻下逐邪等方向。
2. 病势如何传变：卫气营血描述温热由浅入深，三焦辨证描述上、中、下的脏腑病位与气化失常。二者并非互相排斥：例如上焦肺卫证可以仍在卫分，逆传心包则已入营；中焦阳明腑实多属气分，久羁伤阴又可进入下焦少阴。
3. 邪正消长如何观察：舌色、舌苔、斑疹、齿垢、神志、汗出和脉势是动态指标。温病尤其重视津液：渴与不渴、舌润与舌燥、汗后脉敛与不敛，常比单一体温更能显示热、湿、阴伤和气脱。
4. 治法如何随证转轴：温热宜清透而不可妄用辛温，湿热宜宣化分消而不可一味寒凉滋腻；实热可下，但须辨热结、湿结、液枯与正虚；邪退之后仍须辨余热、阴伤与中气虚，不可见虚象便骤投温补。

“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，入血就恐耗血动血，直须凉血散血。”这不是四个静止标签，而是一条决定药性轻重和治疗先后的路径。（PDF 第 105 页，原书第 101 页）

5.2 《温热论》：卫气营血与临床征象

5.2.1 温邪传变的基本模型

叶天士以“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”概括温病入口和危重转归。肺主气、外合皮毛，故初起虽称“在表”，治法却与伤寒辛温发汗不同：风温用辛凉轻透，夹湿则佐甘淡渗湿。若肺卫之邪不解而渐入营分，可见夜甚无寐、心神不安、舌绛或斑点隐隐，此时应撤去偏于走气的药，转入清营、透热转气。再深至血分，则见耗血、动血、斑疹或出血，治当凉血散血。（PDF 第 104 页，原书第 100 页）

温病传变快，却并非必然机械地依次经过卫、气、营、血。气分之邪可以流连三焦，近似少阳半表半里，但治疗重在“分消上下之势”，如杏仁、厚朴、茯苓一类宣降渗化，或以温胆汤走泄痰热。邪在气分、正气尚能抗邪者还可能战汗而解；战汗后肤冷、倦卧而脉虚软和缓，是邪退正虚、阳气暂未回复，宜静卧候复。若肤冷汗出而脉急疾、躁扰不卧，才是气脱危候，不能把两者混同。（PDF 第 105 页，原书第 101 页）

5.2.2 湿热、三焦与攻下尺度

湿邪黏滞，使温病的“清热”不能等同于一味苦寒。面白而湿胜者须顾阳气，面苍而热盛者须顾津液；清凉至六七分后应留意阳气和津液的恢复。所谓“救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便”，强调湿热证的通阳常靠恢复水道，而不是径投温燥。（PDF 第 105 页，原书第 101 页）

湿热也可在阳明胃肠形成里结，但下法宜轻灵，不可照搬伤寒峻下。判断层次须合看腹部与舌象：

- 脘部痞痛而舌黄浊，可随证用小陷胸汤或泻心汤；若苔白不燥、黄白相兼或灰白不渴，则可能是湿聚、寒湿或气滞，不可乱用苦泄。
- 大腹满、胀、痛，且舌黄甚、灰黄或老黄并见断纹，才支持邪已入里而用轻下；仅有腹满并不能排除太阴湿聚。
- 伤寒便溏常提示邪势已衰，湿温便溏反可能是湿邪未尽；但一旦粪燥，往往说明湿已化燥，继续攻下又会伤津。

5.2.3 舌、斑疹、白痞与齿诊

舌诊在本篇中承担“定位加定性”的双重作用。舌绛提示热入营分；纯绛鲜泽而伴神昏，重心包，先用清营开窍，闭证深者方考虑牛黄丸、至宝丹一类。白苔黏腻、涎厚口甜为脾瘴，舌白如粉而滑、边紫绛可见于温疫初入膜原。舌上芒刺是上焦热极的信号，但仍须结合苔的润燥和全身证候，不能见“红”即一概凉血。

斑为点大而隆于皮肤，疹为细碎小粒；斑多属血，疹不少属气，二者都是邪气外露。发出后神清，表示外解里和；出而昏迷，则可能正不胜邪、邪陷心包或胃津枯竭。白痞为湿热伤肺、汗出不彻而见的晶莹小疱，晶亮尚提示邪有出路，枯白如骨则为气液衰竭之象。齿为肾之余、龈为胃之络，齿垢与龈血可以帮助区分胃津受伤和肾液下竭。（PDF 第 106–107 页，原书第 102–103 页）

妇人温病与男子同样遵循上述传变，但经期、胎前、产后使血分更易受损。护胎并不等于拘泥四物汤等滋腻血药；若邪有可解之处，仍要顾及透邪，避免“护胎”反使邪陷。

5.3 《湿热病篇》：湿热相合的辨证层次

5.3.1 提纲与病机

“始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮”是湿热提纲。恶寒来自阳气为湿所遏，并非伤寒风寒束表；渴不引饮则说明热欲饮而湿又阻滞水液。病多落在阳明、太阴：中气实者偏阳明，中气虚者偏太阴；表层可兼少阳三焦，里层郁热又可牵动厥阴相火，故耳聋、干呕、痞厥均可能出现。多数湿热由口鼻而入，内有湿饮停聚者更易内外相引；膜原位居肌肉与胃腑之间，是三焦门户和半表半里之所。（PDF 第 107 页，原书第 103 页）

5.3.2 由表入里、由气入营的辨治

湿在表与肌肉

恶寒、无汗、身重、头痛，宜芳香疏表化湿；关节疼痛而汗不解，说明湿留肌肉，治用滑石、豆卷、茯苓皮、通草等宣化渗湿，不能靠强汗。

湿阻膜原与三焦

寒热如疟、胸痞呕恶，治重开达膜原；皖闷、知饥不食而邪蒙三焦，宜用藿香、佩兰、荷叶、芦尖等轻清芳化。湿伏中焦则辛开苦降，湿流下焦而自利溺赤则淡渗分利。

湿渐化热

舌根白而尖红，表示余湿仍滞、热势已显，宜辛泄佐清；舌光如镜、口大渴、脉细数则胃液已劫，不再适合香燥，应以鲜汁甘寒救液并调畅气机。

痰热与肺胃不和

呕清水、痰多是湿热内留兼木火上逆，可从温胆汤加减；昼夜呕恶、肺胃不和可少量黄连配苏叶辛开苦降；暑邪入肺络而咳喘则宜泻肺通络。

营血与厥阴

神昏痞厥、舌焦红为热灼心包并耗营血，须清营凉血、息风开窍；上下失血或汗血为毒入营分；久病默默不语而芳香开窍无效，提示邪入厥阴、络脉瘀闭，可从三甲散搜络透邪理解。

舌象是用药的制动器：全舌白而湿滞阳明可辛开，舌根白尖红须辛开中兼清热，舌光少津则停用香燥。白虎加苍术汤用于湿与热俱盛、壮热口渴、自汗身重且脉洪大而长；清暑益气汤则用于湿热伤气、倦怠少气、自汗脉虚。二方都可见身热汗出，但一实一虚，关键在脉力、精神和气短。（PDF 第 108-109 页，原书第 104-105 页）

5.4 《温病条辨》：三焦体系与方证阶梯

5.4.1 九类温病及上焦总纲

吴鞠通列风温、温热、温疫、温毒、暑温、湿温、秋燥、冬温、温疟九类，差异来自时令、病邪兼夹和素体，但共同点是多先见上焦手太阴证。上焦辨治的核心不是背诵方名，而是识别辛凉法的轻重与病位变化：

- 邪在肺卫：银翘散为辛凉平剂，适合发热口渴、咳嗽等温热初起；桑菊饮为辛凉轻剂，适合咳嗽突出而身热不甚；白虎汤为辛凉重剂，须见脉洪、舌黄、渴甚、大汗、恶热等气分热盛。

- 气津两伤：白虎证兼大汗、脉芤或散大，可加人参益气生津；生脉散用于汗多、喘喝、脉散大而欲脱。白虎汤有明确禁忌：脉浮弦细、脉沉、不渴或汗不出者均不可轻投。
- 气营两燔与出血：玉女煎加减清气凉营，犀角地黄汤合银翘散用于血从上溢。舌绛干而反不渴提示热在营分，清营汤透热养阴。
- 心包闭阻：神昏谵语、舌謇肢厥，治须清宫、开窍。安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹各有侧重，均属于危重证的经典治法，不应脱离辨证自行使用。
- 温毒：咽喉、耳前后及颊部红肿为热毒壅聚上焦，普济消毒饮加减须兼顾初起透邪和后期清热解毒，原文特意去除升麻、柴胡，意在防止升提助火。

暑温虽似伤寒，却以右脉洪大数、口渴面赤、大汗为辨；无汗可用新加香薷饮，汗出而热盛用白虎，兼湿身重加苍术，气津欲脱用生脉散。暑温入营见夜寐不安、舌赤、谵语，可用清营汤；舌白滑者说明湿重，不得误用滋腻凉营。伏暑与湿温同源异态，须合看舌色、汗出和湿重程度。（PDF 第 109–112 页，原书第 105–108 页）

5.4.2 秋燥：温润肺胃而非笼统清火

秋燥伤手太阴气分、咳而右脉数大，用桑杏汤辛凉宣润；燥伤肺胃阴分、久热久咳，用沙参麦冬汤甘寒养阴；燥气化火、耳目咽喉等清窍不利，用翘荷汤轻清上达；诸气膈郁、痰喘呕因燥而作，则用清燥救肺汤辛凉甘润，兼顾宣肺、益气和养阴。四方从轻宣、甘润、清窍到救肺逐层加深，不能只凭“秋天咳嗽”互相替代。（PDF 第 113 页，原书第 109 页）

5.4.3 中焦：阳明热结、津枯与湿郁

中焦以胃与脾为核心。面赤声重、呼吸粗、大便闭、舌老黄或黑有芒刺、日晡热甚，属阳明温病；脉浮洪躁用白虎清气，脉沉数有力而腑实用大承气。下法须按“热结”和“液干”的比例分层：

1. 热结液干俱重，以大承气急下存阴。
2. 热结偏重、津伤较轻，以调胃承气缓下。
3. 液干为主、热结较轻，以增液汤“增水行舟”；仍不便时再合调胃承气。
4. 下后汗出或邪退津亏，以益胃汤复胃阴；舌黑而脉仍有力可微和，脉弱则先增液，体现“攻不忘正”。

下之不通还有五种机制：正虚不能运药用新加黄龙汤；肺气不降、痰热壅塞用宣白承气汤；小肠热结、小便赤痛用导赤承气汤；心包闭阻用牛黄承气汤；津枯无水行舟用增液承气汤。相同的“大便不下”由气、津、肺、心包或二便气化不同所致，不能只加大大黄剂量。（PDF 第 114–115 页，原书第 110–111 页）

湿温中焦证则以舌滑、渴不多饮、胸痞、便溏和脉缓为主。三石汤处理暑温三焦气分热盛，加味清宫汤处理久留入血，安宫或紫雪用于热闭内窍。杏仁滑石汤适合暑湿三焦俱受而痞、呕、烦渴、自利并见。五个加减正气散依次处理三焦湿郁、湿阻气分、秽湿酿热、湿兼食滞和湿重泄泻；黄芩滑石汤用在湿热并重而汗后复热；宣痹汤和薏苡竹叶散则把湿热从经络、肌表和三焦分消。其共同原则是辛开、苦降、淡渗配伍，既不能纯辛走表，也不能纯苦寒清热。（PDF 第 116–118 页，原书第 112–114 页）

5.4.4 下焦：真阴、虚风与蓄血

温邪久羁中焦，或误汗、误下，最终容易耗伤肝肾真阴。下焦方证呈现一条由阴伤到虚风内动的阶梯：

加减复脉汤及一、二、三甲复脉汤

脉虚大、手足心热、舌绛少苔为阴伤；随着手指蠕动、痉厥欲作及心中大动，逐步加入牡蛎、鳖甲、龟板潜阳息风。

黄连阿胶汤

真阴欲竭而壮火仍炽，心烦不得卧，取苦寒清火与甘咸养阴并行。

青蒿鳖甲汤

夜热早凉、热退无汗，表示邪伏阴分，治以养阴透热。

大定风珠

邪少虚多、神倦瘈瘲、脉弱欲脱，用厚味滋阴、潜阳息风。若壮火尚盛，不得提前使用，以免恋邪。

桃仁承气汤与抵挡汤

少腹坚满、小便自利、夜热昼凉、脉沉实为蓄血，治在逐瘀，不可误认单纯阴虚。

连梅汤与宣清导浊汤

前者治暑邪深入少阴、厥阴而消渴麻痹，酸甘化阴兼苦泄；后者治湿温久羁、三焦弥漫、神昏窍阻而少腹硬满，以淡渗导浊通便。

《杂说治病法论》以“治上焦如羽，非轻不举；治中焦如衡，非平不安；治下焦如权，非重不沉”概括药性、剂量和病位的适配，并非固定一套方剂。（PDF 第 119–120 页，原书第 115–116 页）

5.5 温疫学说与后世扩展

5.5.1 《外感温病篇》与《温疫论》

《外感温病篇》以身热、咳嗽、烦渴为风温必见，恶风只是或见；肺主卫而胃为卫之本，故肺胃是风温内外传变的共同枢纽。

吴又可《温疫论》更明确提出疫病由天地间“异气”所感，不属于一般风寒暑湿；邪从口鼻进入，停于夹脊之前、肠胃之后的膜原。初起憎寒后发热，脉不浮不沉而数，日晡热甚，虽有头身痛也不是太阳表证，妄用麻桂会伤表，过早攻下又伤胃，宜以达原饮疏利膜原。（PDF 第 120–121 页，原书第 116–117 页）

其“逐邪勿拘结粪”并非主张见热即下，而是说攻下目的在逐里邪，不应把燥屎作为唯一门槛；即使便溏而秽臭如败酱，也可能有应下之邪。疫邪在气分可经战汗顿解，在血分可由发斑渐解。病后阴血未复而余焰尚存，骤投参、芪、白术可能壅邪；最稳妥的善后常是静养、节食，再按阴枯、痰湿等素体区别调理。

原文称“九传”，但列法存在名数歧义；其意在概括但表不里、但里不表、表而再表、里而再里、表里分传及再分传、表里偏胜、先表后里或先里后表等趋向，并非一个患者必经九站。核心仍是追踪邪之所在，避免只见症状而不逐邪。（PDF 第 122 页，原书第 118 页）

5.5.2 《广温疫论》与《伤寒温疫条辨》

《广温疫论》以面色松缓垢晦、油腻如烟熏提示疫邪蒸湿，不宜轻用辛热。其汗、下、清三法与伤寒比较鲜明：时疫汗法宜辛凉救阴且常兼通里；下法重在泻郁热，可不待表证全罢，但应依胸上、胸膈、胸胁、脐上、脐下及三焦俱结选择贝母、小陷胸、大柴胡或三承气；清法则按营卫、胸膈、肠胃、心包深浅分层。这里的“早下、多下”属于特定疫病理论，不能脱离腹证、舌脉与正气强弱机械套用。（PDF 第 122–123 页，原书第 118–119 页）

《伤寒温疫条辨》从脉证与病向区分两者：伤寒多由表入里，初起恶寒而不渴、脉浮紧；温病多内有郁热而外达，初起即可口渴咽干、脉洪滑，重证反可沉伏甚至闭绝，不能把沉伏一律解释为阴寒。其治温病强调辛凉苦寒开导里热，反对辛温“抱薪投火”。升降散以僵蚕、蝉蜕、姜黄、大黄配伍，体现升清、降浊、散郁、逐邪并用；原文同时告诫应随机应变，不可执一方统治所有温病。（PDF 第 123–125 页，原书第 119–121 页）

5.5.3 疫疹、六淫与常用方证补充

《疫疹一得》以清瘟败毒饮治表里火热俱盛、狂躁烦心、咽痛斑疹及吐衄，方中石膏、犀角、生地、黄连等合用，脉势与毒热轻重决定剂量。此处原方含犀角等现代受保护动物药，仅供经典方义学习，临床替代和剂量必须遵循现行法规与专业规范。

《通俗伤寒论》用短句统摄六淫治法：外风宜散、内风宜熄，表寒宜汗、里寒宜温，暑病宜清而伏暑可下，湿热重芳化苦泄，燥证按上焦救津、中焦增液、下焦滋阴递进。蒿芩清胆汤用于少阳相火上逆、痰湿内阻而寒轻热重、口苦胸胁闷；羚角钩藤汤用于热盛动风。二方一个和解少阳兼清化痰湿，一个凉肝息风养阴，病机不可混淆。（PDF 第 126 页，原书第 122 页）

5.6 伏气、湿温与温伤之辨

《三时伏气外感篇》把春温解释为冬令收藏不固、伏邪化热而发，风温则为春月新感、先伤肺卫并可逆传心包；夏暑多从阳明，白虎汤是清气分暑热的代表。其要点是伏气与新感可以表现相近，却在病史、初起里热和传变方向上不同。（PDF 第 127 页，原书第 123 页）

《温热经纬》所载甘露消毒丹是湿温时疫气分证代表方，适合舌苔淡白、厚腻或干黄，兼胸闷、身重、咽肿、黄疸等湿热表现，治以芳香化浊、清热利湿。《随息居重订霍乱论》的连朴饮用于湿热蕴伏、霍乱吐泻兼食滞痰阻；《时病论》的芳香化浊法治霉湿秽浊，宣透膜原法治湿症寒甚热微、身重脘闷。这几组方都含芳香辛开之意，但一个重清热化湿，一个重和胃降逆，一个重开达膜原。（PDF 第 127–128 页，原书第 123–124 页）

《温热逢源》再次从病程方向作总结：伤寒随感即发，由表传里，初起恶寒不渴；温病可由伏寒化热，虽见头项强痛等表象，里热已先盛，常见口渴、溲黄、尺肤热。故二者看似同有表证，治法却一温一凉。此说属于伏气温病理论，与叶天士“温邪上受”和吴又可“异气从口鼻入”并列存在，复习时应区分学派模型，不能强行合并为唯一病因。（PDF 第 128–129 页，原书第 124–125 页）

5.7 综合辨证提要

面对发热性疾病的经典条文，可按以下顺序整理信息：

1. 先辨伤寒、温热、湿热、暑、燥或疫邪倾向：重点看恶寒与口渴出现的先后、舌苔润燥、脉浮沉与有力无力、胸痞身重以及流行性接触背景。
2. 再定卫、气、营、血的深浅：卫分看肺卫表证，气分看高热汗渴，营分看舌绛夜甚和神志，血分看斑疹出血与动风。
3. 同时定上、中、下焦病位：上焦重肺与心包，中焦重胃肠热结和脾湿，下焦重肝肾阴伤、虚风和蓄血。
4. 最后辨邪正比例与津液状态：同为汗出，可是邪解、气分热盛、气脱或湿郁不彻；同为便闭，可是阳明实热、津枯、肺气不降、心包闭阻或蓄血。
5. 治疗上遵守“给邪以出路、给正气留余地”：透表不可过汗，清热不可冰伏，祛湿不可伤津，攻下不可只看便次，养阴不可滋腻恋邪，开窍不可替代清解病因。

5.8 校勘与用药说明

- PDF 第 106 页原文“可与小陷胸汤或泻心汤”据方名及上下文校为“可与小陷胸汤或泻心汤”。
- PDF 第 106 页“白（缺字）”为原文件缺字，结合“小粒如水晶色”及温病术语校为“白痞”。
- PDF 第 113 页“诸气（缺字）郁”系原文件缺字，据《素问》通行文本校为“诸气膈郁”。
- PDF 第 108 页“醉地鳖虫”按方药炮制语义保留为原文记录，未擅自改作其他炮制法；PDF 第 124 页“心胞络”在笔记中统一规范为“心包络”。
- 古方剂量、炮制、禁忌与现代药材来源并不等同于现行临床规范；犀角、穿山甲等涉及保护动物或禁限用药材，本文仅作经典考试与学术脉络整理，不构成处方或自用建议。

6、 跨典整合与复习索引

6.1 同一病机在不同经典中的展开

正气与未病

《内经》强调“治未病”、顺四时、节饮食起居；《金匱》把它落实为“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”；《伤寒论》则在病已发生后通过顾护胃气、审慎汗下防止坏病；温病学进一步提醒热病初期不可妄用辛温，疫后不可骤补壅邪。四者共同说明预防和治疗都要保护正气，但“扶正”不是抽象地补，而是先辨何处虚、何邪未去。

营卫、气血与津液

《内经》解释营卫来源、运行和昼夜节律；《伤寒论》以桂枝汤、麻黄汤等处理营卫失和和表闭，并以汗、渴、小便观察津液；《金匱》从血痹、虚劳、痰饮水气扩展到久病失养；温病学用卫气营血追踪热邪耗津动血。麻木、汗出、口渴、尿少、舌燥等表面相近的症状，必须放回营卫气血津液的动态链条中辨别。

肺、脾、胃与水道

《内经》以肺主气、脾胃受纳运化、三焦决渎为生理基础；《金匱》以痰饮、水气、肺

痿肺病表现水液失布；湿温学则把湿邪困阻阳明太阴、三焦分消和小便不利作为主要病机。咳喘伴痰、胸痞、身重或尿少，不能只按“肺病”处理，应同时判断水饮、湿热、胃气和气化。

神志与开窍

《内经》把心神、魂魄、精气和目脑联系起来；《伤寒论》以烦躁、谵语、惊狂辨阳明热实、火逆及少阴危候；《金匱》保留百合病、奔豚、惊悸等神志病机；温病学在营血、心包闭阻时以舌謇、肢厥、神昏为转危指标。开窍药只能解决“闭”，不能替代清热、凉血、化湿或救阴。

病势与时间

《内经》用四时和一日节律解释病势早晚，《伤寒论》用传经、合病、并病和误治描述动态，《金匱》重视病程先后和卒病、痼疾的缓急，《温热论》以逆传心包、《温病条辨》以三焦传变说明热势。时间是证据之一，不是机械套方的依据。

6.2 高频鉴别：先列证候，再选方

1. 桂枝汤、麻黄汤与葛根汤：桂枝汤抓“汗出、恶风、脉缓、营卫不和”；麻黄汤抓“无汗、恶寒、脉浮紧、表实”；葛根汤抓太阳表实兼项背强几几，或下利而邪在表。汗出与否、脉紧缓和项背症状比“发热”本身更有区分度。
2. 小柴胡汤、黄芩汤与四逆散：少阳枢机不利见往来寒热、胸胁苦满、口苦咽干、默默不欲饮食，重在和解；太少合病下利而热在少阳，可从黄芩汤类清利；四逆散的四肢厥冷来自气机郁滞而非阳亡，须辨脉不微、神不衰。
3. 承气类与温病下法：阳明燥实依腹满痛、潮热、谵语、燥屎和脉实选大承气、小承气或调胃承气；温病还要辨液枯、肺气不降、心包闭阻和湿热旁流，故有增液承气、宣白承气、牛黄承气等分支。大便不通不是唯一下法指征。
4. 四逆汤、通脉四逆汤与真武汤：四肢厥冷若伴下利清谷、脉微欲绝，是少阴阳衰欲脱的亡阳证，须回阳救逆；通脉四逆汤用于阳虚更甚、脉微欲绝；真武汤偏阳虚水泛，见小便不利、身重、悸眩、腹痛或四肢沉重。三者均见“冷”，但水湿和脉势不同。
5. 乌梅丸、干姜黄连黄芩人参汤与半夏泻心汤：厥阴寒热错杂、蛔厥和久利可用乌梅丸；上热下寒、呕吐下利而中焦虚可寒温并调；心下痞、肠鸣下利且夹寒热错杂则从泻心汤类。关键是寒热上下的组合，而不是单看“腹泻”。
6. 湿热与阴虚：身热、身重、胸痞、舌白或腻、渴不引饮偏湿热；夜热早凉、舌绛少苔、脉细数偏阴虚伏热。前者宜芳化、苦泄、淡渗，后者宜养阴透热；误以滋腻补阴治湿，会使邪恋不解。
7. 斑、疹、白痞与出血：斑多血分、疹多气分；白痞多见湿郁卫分、汗出不彻，晶亮者提示湿邪尚有外达，枯白如骨才提示气液竭；紫黑斑、齿上结瓣和舌绛干燥则提示热深动血。必须结合神志、脉势和津液，不能仅凭颜色判断轻重。
8. 咳喘的四条路：寒饮射肺以小青龙或射干麻黄汤，肺痈脓毒以苇茎汤等排脓，湿热犯肺以宣化清利，温燥伤肺以桑杏、沙参麦冬或清燥救肺。咳嗽是症状，不是方证。

6.3 方证记忆的最小单元

复习每一方时建议固定写下六项：

证机

邪在何处、何性，正气和津液如何。

主症

至少记录一个主症、一个兼症和一个关键舌脉。

治法

用动词表述，如解肌、和解、温阳、清气、透营、凉血、化湿、利水、开窍或养阴。

方义

只记君臣佐使或最能体现病机的两三味药，不必把所有剂量当作死记内容。

禁忌

记录最容易误用的相反证候，例如表虚自汗且无表实依据者忌用麻黄峻汗，舌白滑而无营热者忌清营，脉沉兼不渴、汗不出等无气分实热者忌白虎，湿苔未化者忌滋腻凉血。

转归

写明有效后应出现什么变化，以及出现何种脉症代表传变、脱证或需要换法。

6.4 考前复盘顺序

1. 第一轮只看四部经典的总纲和每篇标题，画出“生理基础-外感病-杂病-温病”的地图。
2. 第二轮按病机重组：营卫不和、阳明腑实、少阳枢机、脾阳虚湿盛、少阴阴阳两伤、痰饮水气、瘀血、湿热和温热伤阴。
3. 第三轮按相似症状做鉴别卡：发热、汗出、咳喘、呕吐、下利、口渴、厥冷、失眠、神昏、腹痛和小便不利。
4. 第四轮只复习禁忌和转归。经典考试常以“何时不可用某方”“误治后如何变证”检验是否真正理解方证。
5. 最后一轮回看 PDF 原页，核对古字、方名和条文编号；凡笔记标为“校勘疑点”的内容，按底本或老师指定版本作最终取舍。

6.5 本次校勘的总体原则

能由原页图像、通行篇名或上下文确定的缺字，已在相关章节直接改正并说明；只能凭后世版本推测而不能确认的字，则改写为不依赖单字的病机概括，不制造“确定”的伪引文。最终笔记因此优先保证逻辑和可复核性，而不把 OCR 猜测冒充原典定本。

一句话总括：以《内经》立生理与治未病之本，以《伤寒论》明六经动态与方证，以《金匱要略》扩展脏腑杂病和虚实夹杂，以温病学辨温热、湿热、疫邪及伤阴传变；临证始终围绕病位、病性、邪正、津液和出路五项复核。

学习边界：古方条文是历史医学文本。本文不提供个体化处方；涉及高热、意识改变、呼吸困难、出血、妊娠和儿童用药时，须及时寻求正规医疗帮助。

7、编者结语

这份笔记的核心不是把一百多页条文压缩成一张方剂清单，而是保留经典的推理结构：先以正常生理和四时节律作参照，再定位病邪所在，辨寒热虚实与津液，判断传变方向，最后选择让邪有出路而又不伤正的治法。复习时若能对每个方证回答“为什么是它、何时不能用、用后看什么变化”，就已经从记忆条文进入了经典辨证。

最终复核提醒：本文为学习笔记，不替代诊疗。高热不退、呼吸困难、神志异常、出血、妊娠或儿童病情应及时由正规医疗机构评估。